AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 11 · CG · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

CIRUGÍA GENERAL

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

69	19	4
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · complemento visual del Tomo 11

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 11 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 39

Índice por tipo de imagen 42

Soluciones de la autoevaluación 44

Signos con nombre propio 41

Autoevaluación 43

01 Abdomen Agudo Quirúrgico

11.1 Apendicitis Aguda

01 Fecalito en la fosa ilíaca derecha 4
02 Puntos y signos del examen 4
03 Apendicitis en la TAC 5
04 Ecografía de apendicitis 5
05 Plastrón o absceso apendicular 6

11.2 Colecistitis Aguda

06 Cálculos con sombra acústica 6
07 Colecistitis aguda en la ecografía 7
08 Cintigrafía HIDA 7

11.3 Diverticulitis Aguda

09 Diverticulitis en la TAC 8
10 Diverticulitis leve (Hinchey 0–IA) 8
11 Absceso pericólico (Hinchey IB–II) 9
12 Diverticulitis perforada (Hinchey IV) 9

11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica

13 Obstrucción de intestino delgado 10
14 Obstrucción de colon 10
15 Vólvulo de sigmoides 11
16 Gas portal en la TAC 11

11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

17 Neumoperitoneo 12
18 Neumoperitoneo evidente 12

02 Pared Abdominal, Hernias & Proctología

11.6 Hernias de Pared Abdominal

19 Hernia inguinoescrotal 13
20 Hernia inguinal directa vs indirecta 13
21 Asa sana y estrangulada 14
22 Hernia umbilical incarcerada 14

11.7 Patología Orificial Benigna

23 Fisura anal 15
24 Prolapso hemorroidal grado IV 15
25 Hemorroide externa trombosada 16
26 Absceso perianal 16
27 Prolapso rectal 17

11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

28 Absceso pilonidal 17
29 Sinus pilonidal 18
30 Hidradenitis supurativa 18
31 Sarcoma de partes blandas en la TAC 19
32 Granuloma piogénico 19

11.19 Patología Vascular Periférica

33 Várices extensas 20
34 Lipodermatoesclerosis 20
35 Úlcera venosa 21

11.20 Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica

36 Manga gástrica 21
37 Bypass en Y de Roux 22

03 Politraumatizado, Cirugía de Urgencia & Quemaduras (ATLS)

11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado

38 Evaluación primaria ATLS 22
39 Cricotiroidotomía 23
40 Uretrografía: rotura uretral 23

Índice por tema · continuación

11.10 Trauma Torácico Mayor

41 Neumotórax a tensión 24
42 Hemotórax 24
43 Tórax volante: movimiento paradójico 25
44 Taponamiento cardíaco en la FAST 25

11.11 Trauma Abdominal

45 Signo del cinturón 26
46 Equimosis de flancos 26
47 FAST positiva 27

11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC)

48 Ojos de mapache 27
49 Signo de Battle 28
50 Hematoma epidural vs subdural 28
51 Fractura con hundimiento 29

11.13 Quemaduras Graves

52 Quemadura de espesor parcial superficial 29
53 Quemadura de espesor parcial profundo 30
54 Quemadura de profundidad mixta 30
55 Escarotomía 31
56 Quemadura de la vía aérea 31
57 Cicatriz hipertrófica 32

04 Preoperatorio, Anestesia & Complicaciones Quirúrgicas

11.16 Fiebre Postoperatoria

58 Atelectasia postoperatoria 32
59 Herida operatoria infectada 33
60 TVP postoperatoria 33

11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

61 Infección incisional superficial 34
62 Hematoma de herida 34
63 Fascitis necrotizante postoperatoria 35
64 Fístula enterocutánea 35

11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

65 Mordedura de gato infectada 36
66 Mordedura de perro 36
67 Herida avulsiva de la mano 37
68 Queloide del lóbulo 37

11.21 Procedimientos de Cirugía Menor

69 Onicectomía parcial 38

01 TEMA 11.1 · APENDICITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

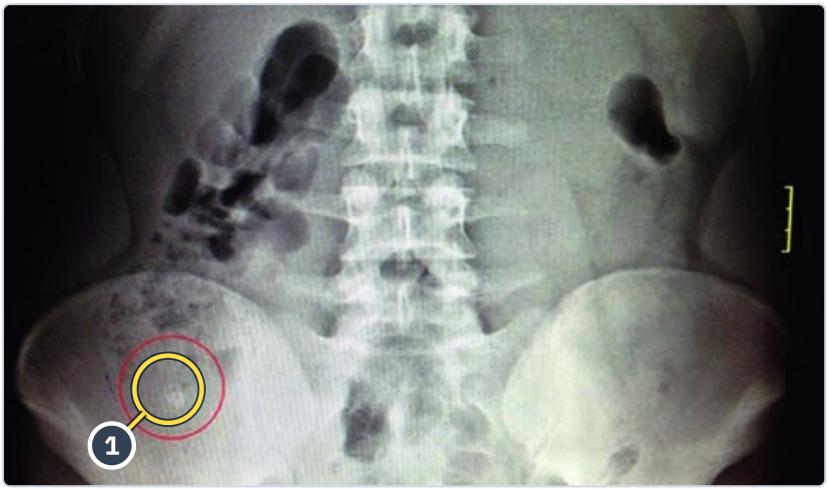


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 158

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fecalito

DIAGNÓSTICO

Fecalito en la fosa ilíaca derecha

Opacidad calcificada en la FID (círculo).

CONDUCTA INICIAL

Apendicitis: el diagnóstico es clínico; cirugía.

4.01.2.006 Apendicitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cálculo ureteral: sobre el trayecto del uréter.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P68** «Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene…» → **Apendicitis aguda**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 7** Tema 11.1

Clase 11.1 en video

02 TEMA 11.1 · APENDICITIS AGUDA

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Punto de McBurney

DIAGNÓSTICO

Puntos y signos del examen

McBurney, Rovsing, Blumberg, psoas y obturador.

CONDUCTA INICIAL

Score de Alvarado para estratificar.

4.01.2.006 Apendicitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Dolor en FII: diverticulitis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 7** Tema 11.1

Clase 11.1 en video

03 TEMA 11.1 · APENDICITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

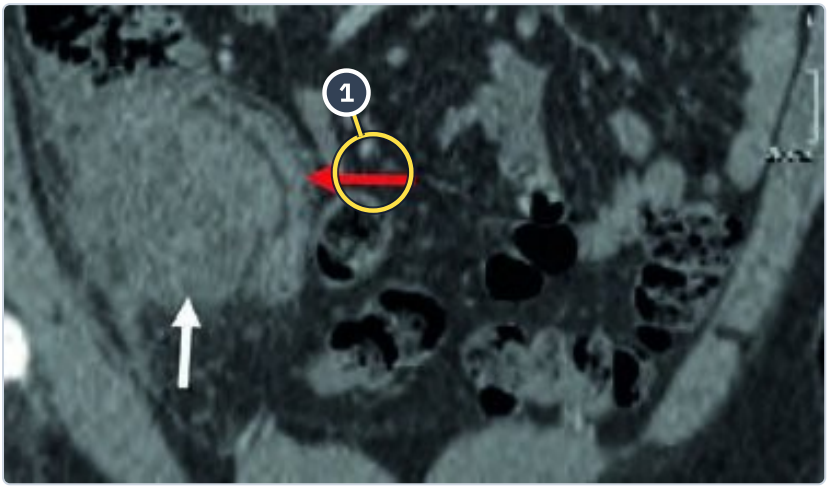


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 41

QUÉ TIENES QUE VER

1 Apéndice engrosado

DIAGNÓSTICO

Apendicitis en la TAC

Apéndice engrosado con inflamación de la grasa (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Adulto no embarazada con duda: TAC con contraste.

4.01.2.006	Apendicitis aguda	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.4.015	TAC de abdomen y pelvis	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ileítis de Crohn: íleon engrosado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 7** Tema 11.1

Clase 11.1 en video

04 TEMA 11.1 · APENDICITIS AGUDA

ECOGRAFÍA

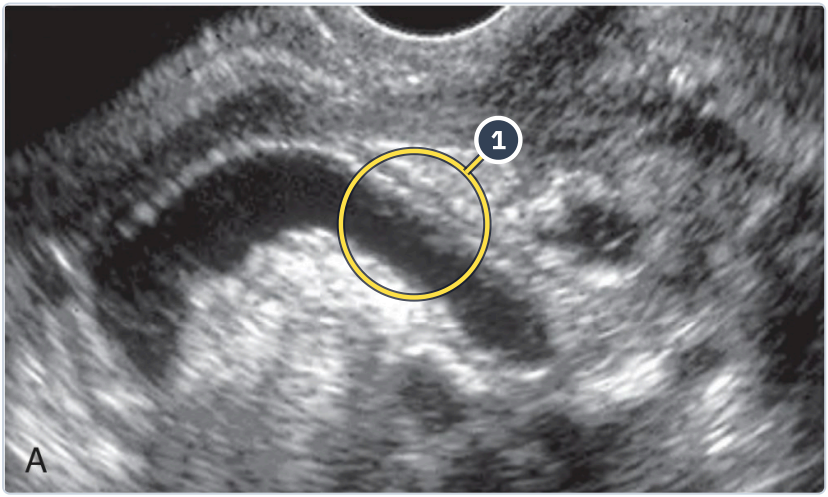


Imagen: Rumack, Diagnostic Ultrasound, 4.ª ed., p. 288

QUÉ TIENES QUE VER

1 Apéndice distendido

DIAGNÓSTICO

Ecografía de apendicitis

Apéndice distendido, de pared gruesa y no compresible.

CONDUCTA INICIAL

Niños y embarazadas: ecografía primero.

4.01.2.006	Apendicitis aguda	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adenitis mesentérica: ganglios grandes, apéndice normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 6** Tema 11.1

Clase 11.1 en video

05 TEMA 11.1 · APENDICITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

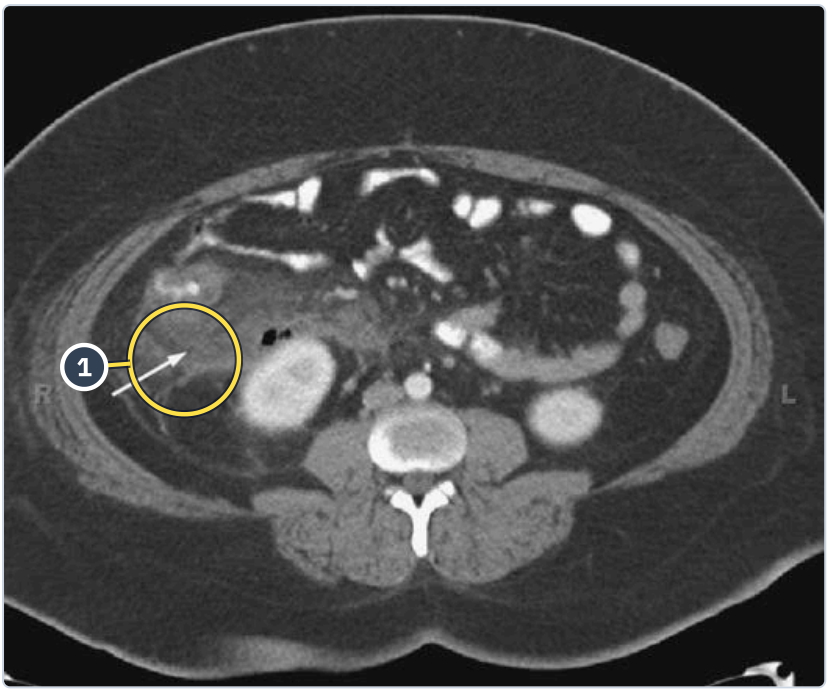


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Plastrón o absceso apendicular

Colección en la FID (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Absceso: antibióticos y drenaje percutáneo; cirugía diferida.

4.01.2.006 **Apendicitis aguda**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cáncer de ciego: masa sin fiebre.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 7** Tema 11.1

Clase 11.1 en video

06 TEMA 11.2 · COLECISTITIS AGUDA

ECOGRAFÍA

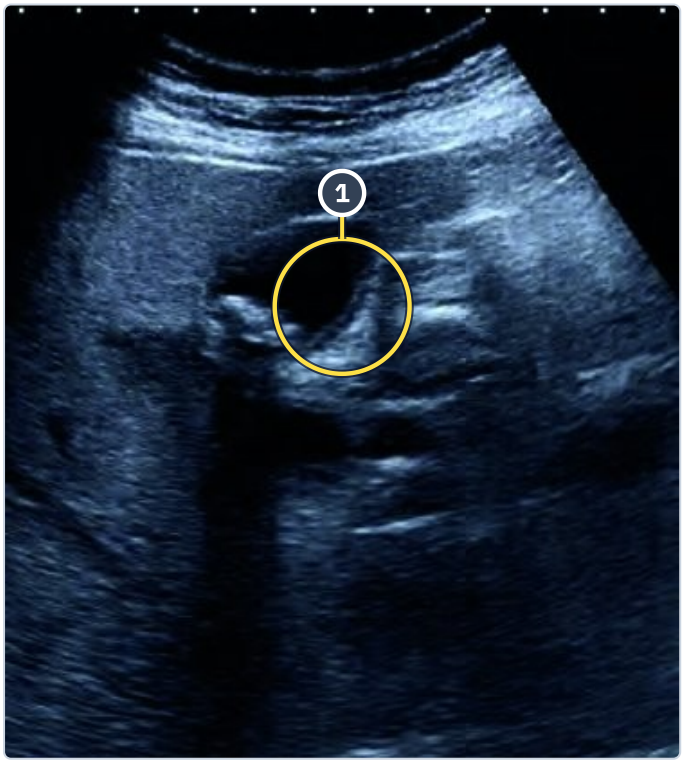


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cálculo con sombra

DIAGNÓSTICO

Cálculos con sombra acústica

Imágenes ecogénicas con sombra posterior.

CONDUCTA INICIAL

Ecografía: examen de elección (S > 95%).

4.01.1.027 **Litiasis biliar**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.4.011 **Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Pólipo: sin sombra y no se mueve.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P125** «Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente…» → **Colelitiasis**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 12** Tema 11.2

Clase 11.2 en video

07 TEMA 11.2 · COLECISTITIS AGUDA

ECOGRAFÍA

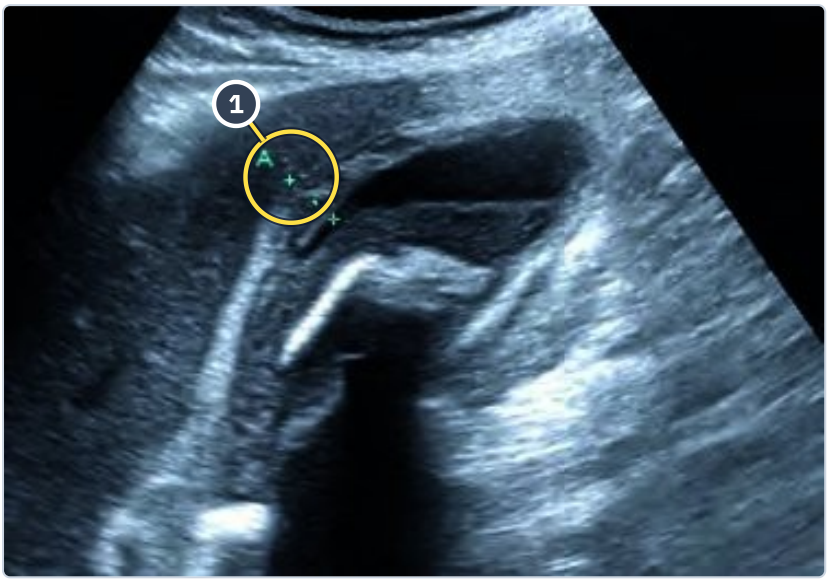


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pared engrosada

DIAGNÓSTICO

Colecistitis aguda en la ecografía

Pared engrosada sobre 4 mm y líquido perivesicular.

CONDUCTA INICIAL

Colecistectomía laparoscópica precoz.

4.01.2.011 Colecistitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipoalbuminemia o ascitis: pared gruesa sin dolor.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P151 «Mujer de 55 años con colecistitis aguda de 48 horas de evolución. Estable hemodinámicamente, fiebre 38°C, leucocitos 14.000. ¿Cuál es el manejo…» → **Colecistectomía laparoscópica precoz (dentro d…**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 12
Tema 11.2

Clase 11.2 en video

08 TEMA 11.2 · COLECISTITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Fundamentals of Diagnostic Radiology (Brant and Helms), p. 1477

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sin relleno vesicular

DIAGNÓSTICO

Cintigrafía HIDA

La vesícula no se llena: conducto cístico obstruido.

CONDUCTA INICIAL

Útil si la ecografía es dudosa.

4.01.2.011 Colecistitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Normal: la vesícula capta en menos de 1 h.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 12
Tema 11.2

Clase 11.2 en video

09 TEMA 11.3 · DIVERTICULITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

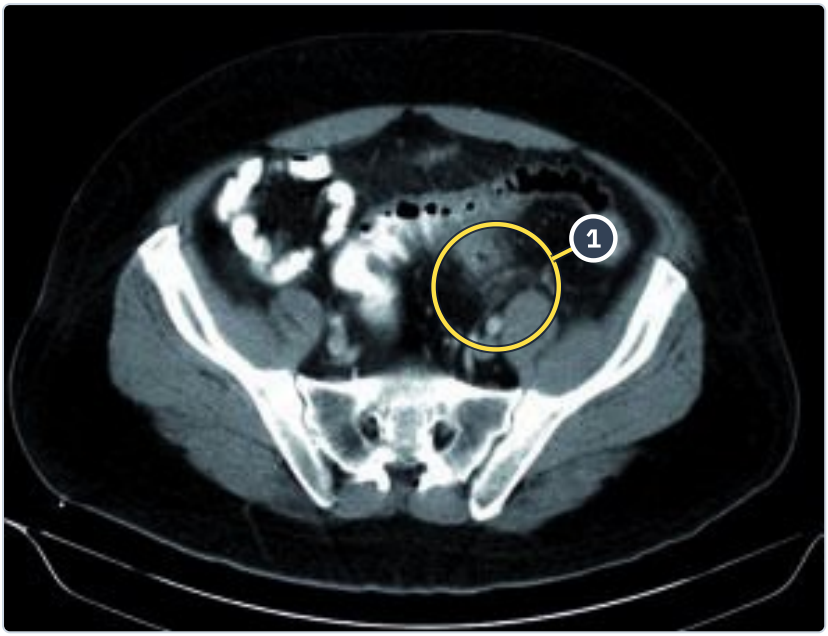


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 142

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sigmoides inflamado

DIAGNÓSTICO

Diverticulitis en la TAC

Sigmoides engrosado con inflamación de la grasa.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste: examen de elección.

4.01.2.008	Enfermedad diverticular complicada	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.4.015	TAC de abdomen y pelvis	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cáncer de colon: engrosamiento largo y sin grasa inflamada.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P33 «Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la…» → **Diverticulitis aguda**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 17
Tema 11.3

Clase 11.3 en video

10 TEMA 11.3 · DIVERTICULITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

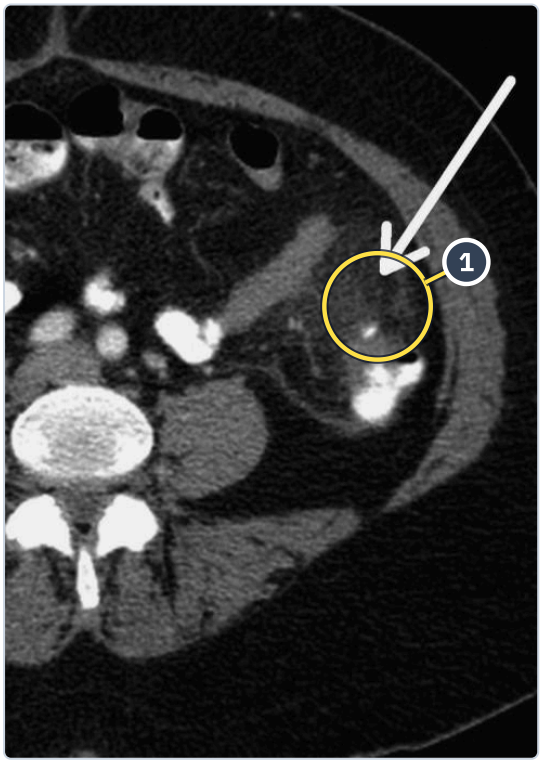


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 370

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pared engrosada

DIAGNÓSTICO

Diverticulitis leve (Hinchey 0–IA)

Engrosamiento de la pared sin absceso (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Manejo ambulatorio con dieta; antibióticos según el caso.

4.01.2.008	Enfermedad diverticular complicada	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.013	Enfermedad diverticular no complicada	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Absceso: colección con pared.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 17
Tema 11.3

Clase 11.3 en video

11 TEMA 11.3 · DIVERTICULITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

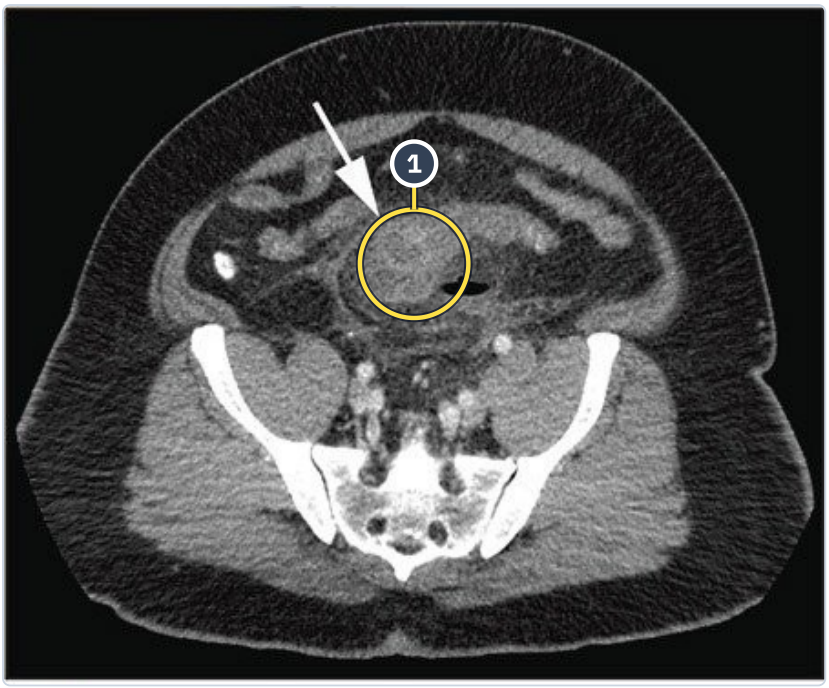


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 371

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Absceso pericólico (Hinchey IB–II)

Colección junto al colon (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Mayor de 4 cm: drenaje percutáneo.

4.01.2.008 Enfermedad diverticular complicada
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Asa con contenido: sin pared gruesa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 16** Tema 11.3

Clase 11.3 en video

12 TEMA 11.3 · DIVERTICULITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

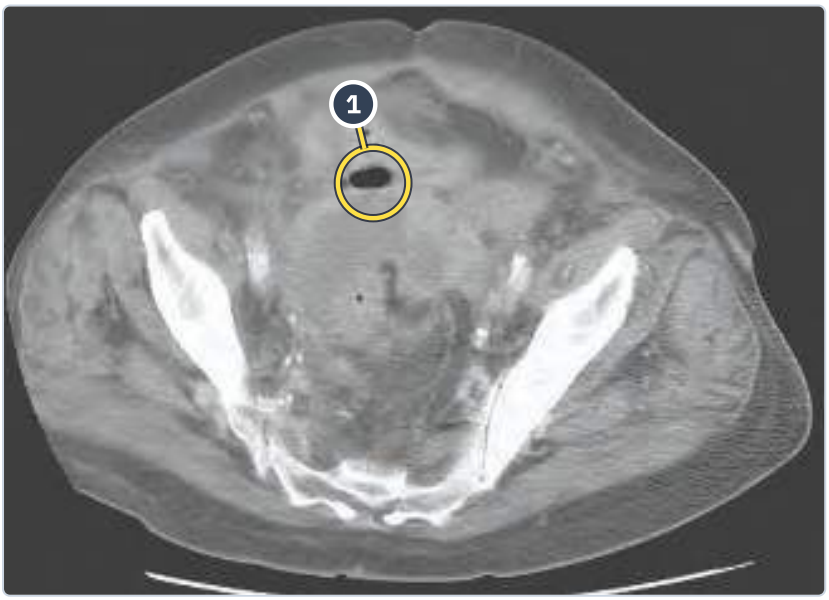


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 1295

QUÉ TIENES QUE VER

1 Aire libre

DIAGNÓSTICO

Diverticulitis perforada (Hinchey IV)

Aire libre y líquido en la pelvis.

CONDUCTA INICIAL

Peritonitis: cirugía de urgencia (Hartmann).

4.01.2.008 Enfermedad diverticular complicada
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.3.004 Colostomías
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hinchey II: absceso localizado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 16** Tema 11.3

Clase 11.3 en video

13 TEMA 11.4 · OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

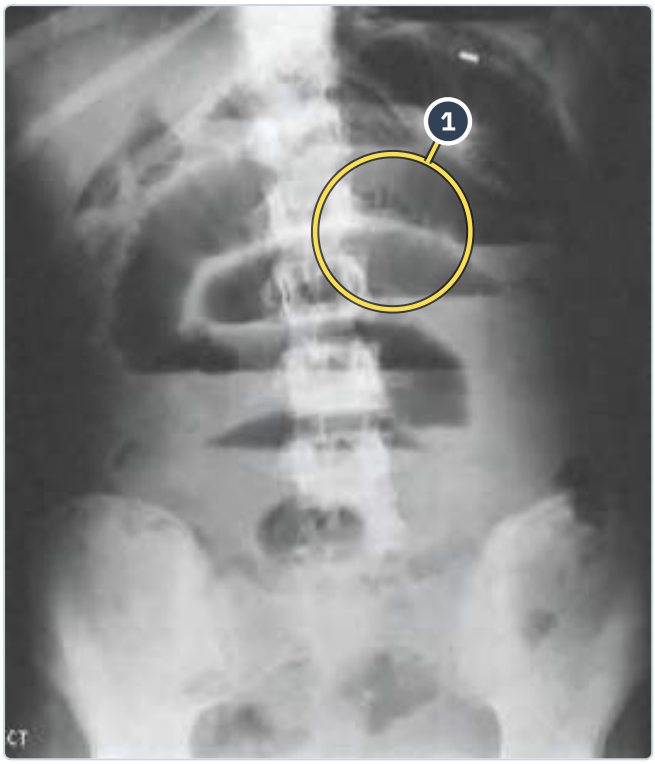


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 1310

QUÉ TIENES QUE VER

1 Asas dilatadas

DIAGNÓSTICO

Obstrucción de intestino delgado

Asas centrales dilatadas con válvulas conniventes.

CONDUCTA INICIAL

Por bridas: régimen cero, sonda nasogástrica e hidratación.

4.01.2.005	Obstrucción Intestinal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.4.002	Radiografía simple de abdomen — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Íleo paralítico: gas también en el colon.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P59 «Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal…» → **Obstrucción intestinal**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 23
Tema 11.4

Clase 11.4 en video

14 TEMA 11.4 · OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

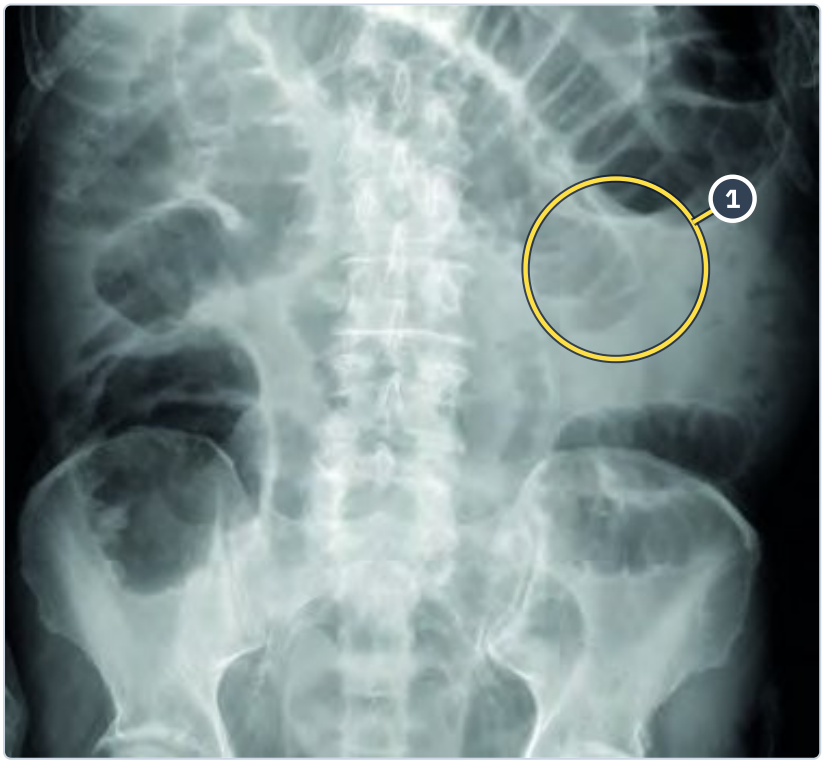


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 26

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colon dilatado

DIAGNÓSTICO

Obstrucción de colon

Marco colónico dilatado en la periferia, con haustras.

CONDUCTA INICIAL

Adulto mayor: cáncer hasta demostrar lo contrario.

4.01.2.005	Obstrucción Intestinal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Delgado: asas centrales.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 21
Tema 11.4

Clase 11.4 en video

15 TEMA 11.4 · OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

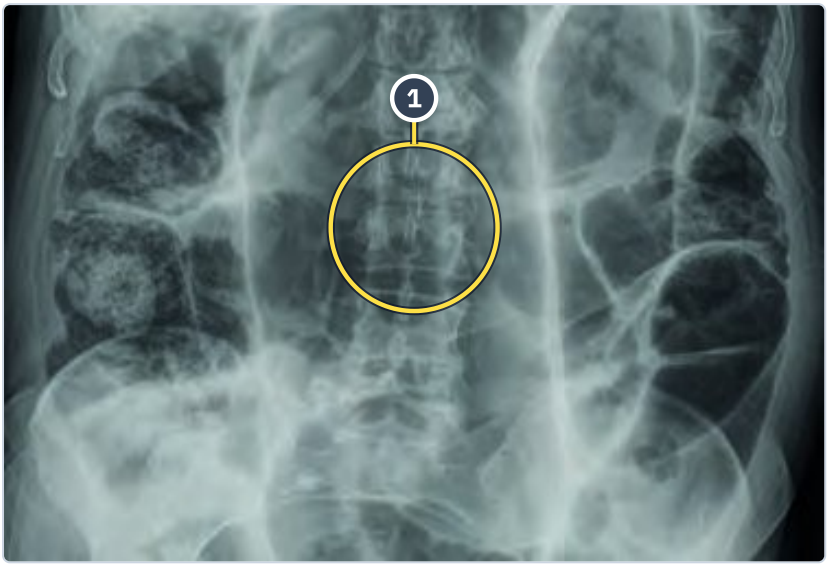


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 26

QUÉ TIENES QUE VER

1 Grano de café

DIAGNÓSTICO

Vólvulo de sigmoides

Asa en grano de café.

CONDUCTA INICIAL

Desvolvulación endoscópica y luego cirugía electiva.

4.01.2.005 **Obstrucción Intestinal**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pseudobstrucción de Ogilvie: sin torsión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 21** Tema 11.4

Clase 11.4 en video

16 TEMA 11.4 · OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

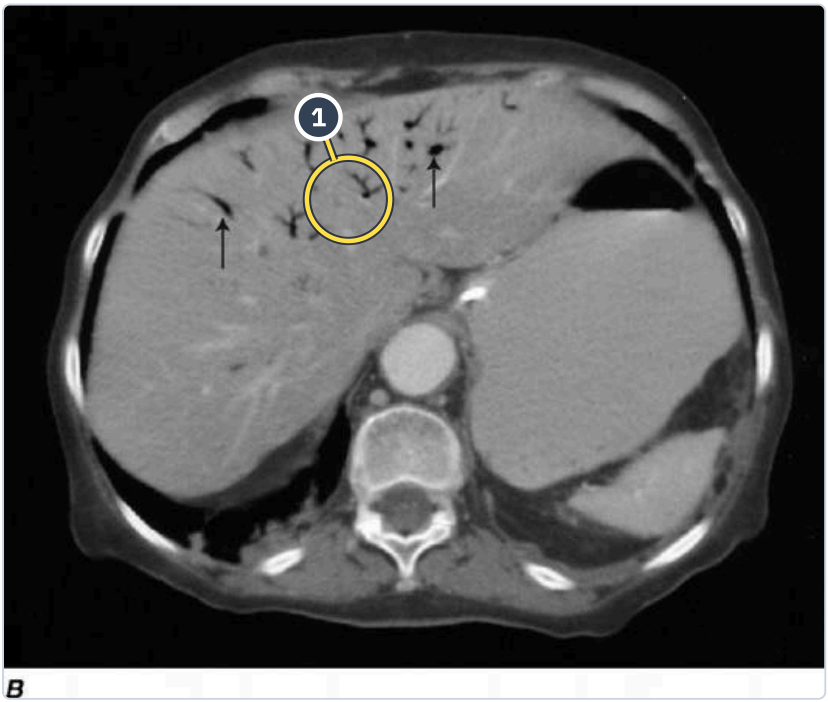


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Gas portal

DIAGNÓSTICO

Gas portal en la TAC

Gas en las ramas portales del hígado (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Isquemia intestinal: cirugía urgente.

4.01.2.005 **Obstrucción Intestinal**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.4.015 **TAC de abdomen y pelvis**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Aerobilia: gas central en la vía biliar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 21** Tema 11.4

Clase 11.4 en video

17 TEMA 11.5 · PERITONITIS GENERALIZADA & ABDOMEN PERFORATIVO (NEUMOPERITONEO)

IMAGEN RADIOLÓGICA

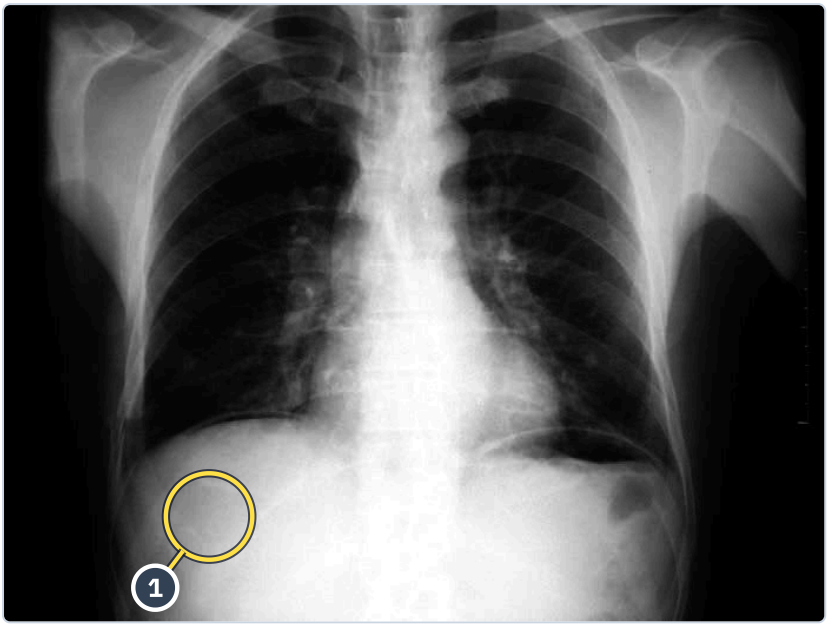


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 65

QUÉ TIENES QUE VER

1 Aire subdiafragmático

DIAGNÓSTICO

Neumoperitoneo

Aire bajo el hemidiafragma en la Rx de tórax de pie.

CONDUCTA INICIAL

Perforación: cirugía de urgencia.

4.01.2.003 Peritonitis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.06.1.030 Úlcera péptica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Signo de Chilaiditi: colon entre hígado y diafragma.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P39** «Se muestra la siguiente radiografía: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?» → **Neumoperitoneo**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 28** Tema 11.5

Clase 11.5 en video

18 TEMA 11.5 · PERITONITIS GENERALIZADA & ABDOMEN PERFORATIVO (NEUMOPERITONEO)

IMAGEN RADIOLÓGICA

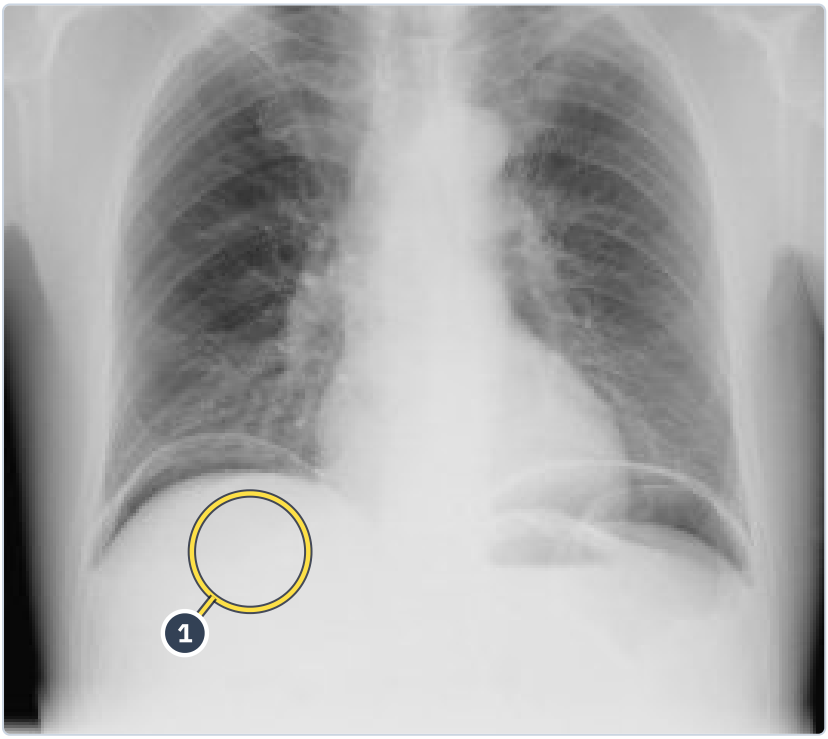


Imagen: Chest X-ray atlas, p. 335

QUÉ TIENES QUE VER

1 Aire libre

DIAGNÓSTICO

Neumoperitoneo evidente

Aire libre bajo ambos diafragmas.

CONDUCTA INICIAL

Peritonitis por úlcera perforada: laparotomía.

4.01.2.003 Peritonitis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cámara gástrica.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P169** «Una paciente de 43 años, multípara, presenta dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Al examen, tiene FC: 110x', PA:…» → **Perforación intestinal**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 28** Tema 11.5

Clase 11.5 en video

19 TEMA 11.6 · HERNIAS DE PARED ABDOMINAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

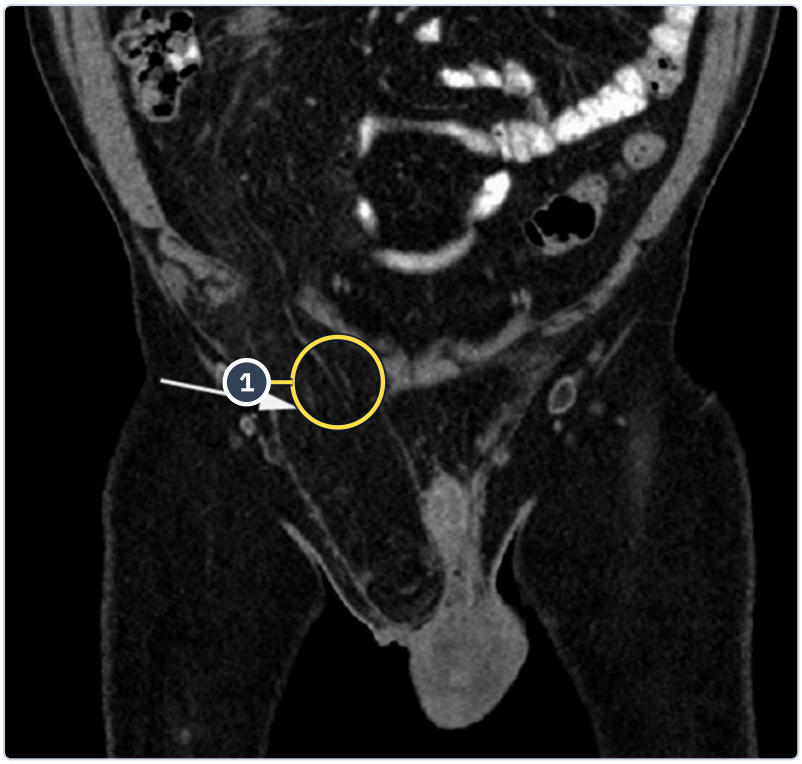


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 393

QUÉ TIENES QUE VER

1. Saco herniario

DIAGNÓSTICO

Hernia inguinoescrotal

Saco herniario que baja al escroto (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Hernioplastia electiva.

4.01.1.021 Hernias, eventraciones y evisceraciones
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hidrocele: transilumina.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P144 «Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es dolorosa y se asocia a náuseas y dolor…» → **Hernia femoral**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 34
Tema 11.6

Clase 11.6 en video

20 TEMA 11.6 · HERNIAS DE PARED ABDOMINAL

ESQUEMA

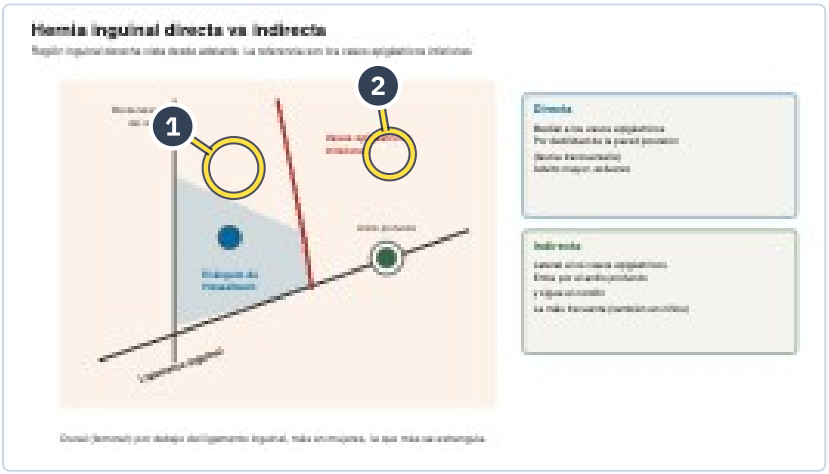


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Triángulo de Hesselbach
2. Anillo profundo

DIAGNÓSTICO

Hernia inguinal directa vs indirecta

Directa: medial a los vasos epigástricos, por el triángulo de Hesselbach.

CONDUCTA INICIAL

Indirecta: congénita, la más frecuente.

4.01.1.021 Hernias, eventraciones y evisceraciones
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Crural: bajo el ligamento inguinal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 34
Tema 11.6

Clase 11.6 en video

21 TEMA 11.6 · HERNIAS DE PARED ABDOMINAL

ESQUEMA

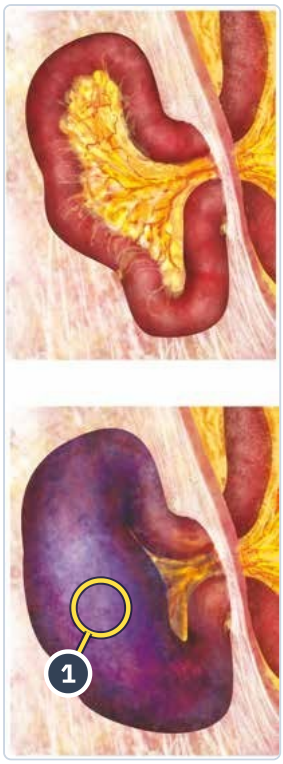


Imagen: Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 56

QUÉ TIENES QUE VER

1 Asa estrangulada

DIAGNÓSTICO

Asa sana y estrangulada

La estrangulada está violácea por isquemia.

CONDUCTA INICIAL

Estrangulación: cirugía urgente.

4.01.1.021 Hernias, eventraciones y evisceraciones

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Incarcerada: irreductible pero viable.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 35** Tema 11.6

Clase 11.6 en video

22 TEMA 11.6 · HERNIAS DE PARED ABDOMINAL

FOTO CLÍNICA

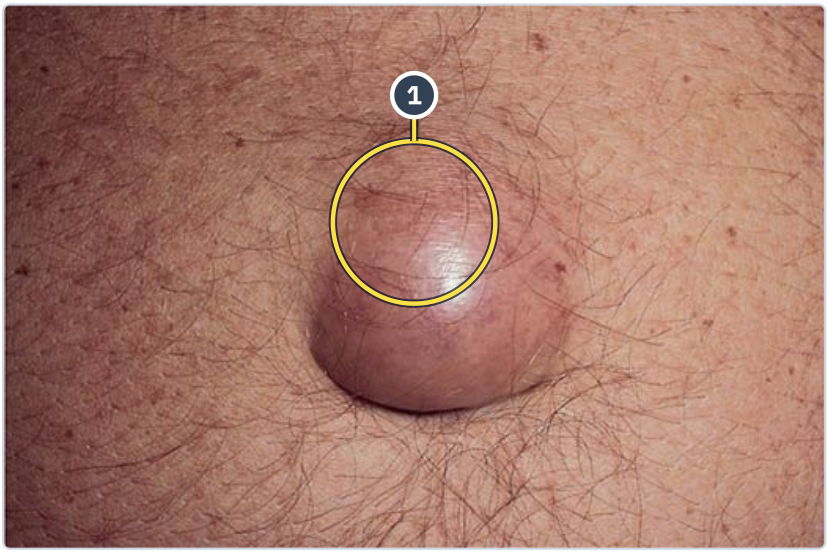


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 201

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hernia

DIAGNÓSTICO

Hernia umbilical incarcerada

Aumento de volumen umbilical tenso con inflamación.

CONDUCTA INICIAL

Con signos inflamatorios: cirugía urgente.

4.01.1.021 Hernias, eventraciones y evisceraciones

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hernia umbilical del lactante: se cierra sola.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 37** Tema 11.6

Clase 11.6 en video

23 TEMA 11.7 · PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA

FOTO CLÍNICA

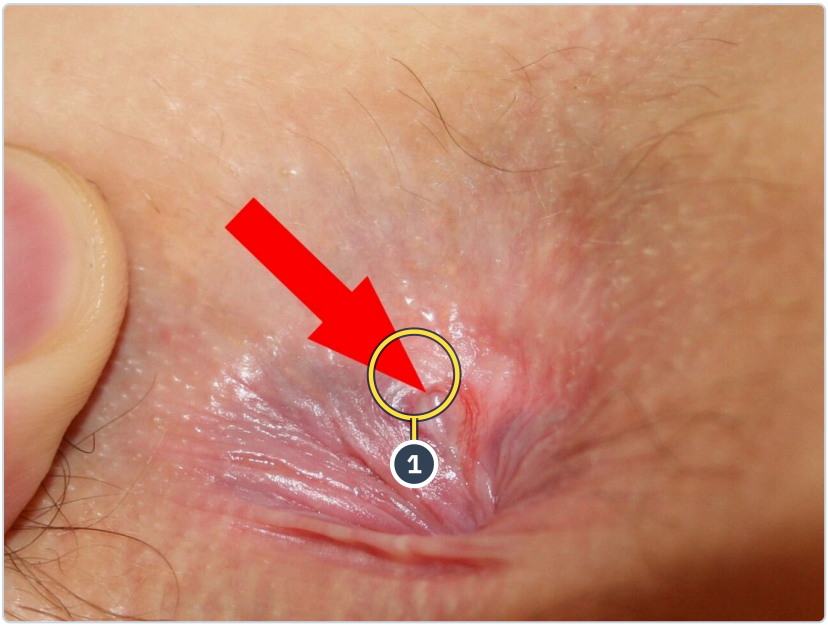


Imagen: Wikimedia Commons «Anal fissure 1.jpg», Public domain, Bernardo Gui

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fisura

DIAGNÓSTICO

Fisura anal

Desgarro en la línea media posterior (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Fibra, baños de asiento y nifedipino tópico.

4.01.1.020 Fisura anorectal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fisura lateral: Crohn, VIH, cáncer.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P54 «Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persis- tiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas…» → **Fisura anal**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 41
Tema 11.7

Clase 11.7 en video

24 TEMA 11.7 · PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA

FOTO CLÍNICA

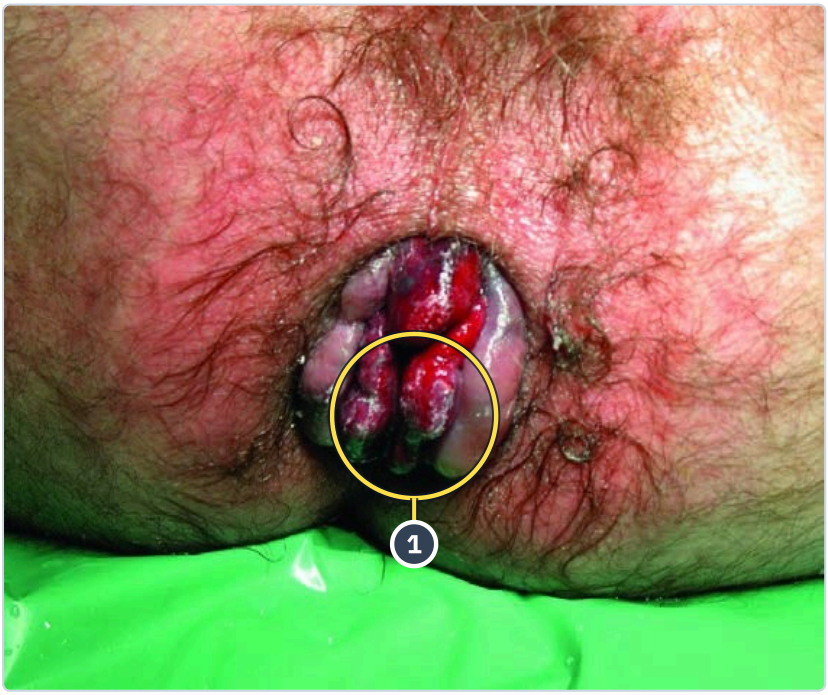


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 149

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hemorroides prolapsadas

DIAGNÓSTICO

Prolapso hemorroidal grado IV

Hemorroides internas prolapsadas que no se reducen.

CONDUCTA INICIAL

Grados III y IV: hemorroidectomía.

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Prolapso rectal: pliegues concéntricos.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 41
Tema 11.7

Clase 11.7 en video

25 TEMA 11.7 · PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA

FOTO CLÍNICA

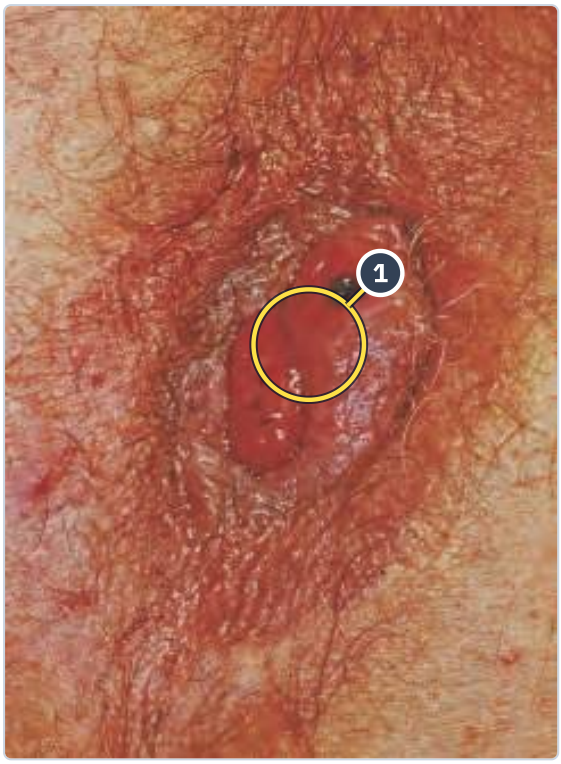


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 1382

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trombo

DIAGNÓSTICO

Hemorroide externa trombosada

Nódulo violáceo y tenso bajo la línea dentada.

CONDUCTA INICIAL

Menos de 72 h: trombectomía.

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Absceso perianal: fluctuante y febril.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P27 «Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. ¿Cuál es el…» → **Trombectomía hemorroidal bajo anestesia**…

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

p. 41

Tema 11.7

Clase 11.7 en video

26 TEMA 11.7 · PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 363

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Absceso perianal

Aumento de volumen eritematoso y fluctuante junto al ano.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje quirúrgico.

4.01.1.017 Abscesos y fístulas ano rectales

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemorroide trombosada.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P41 «Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de…» → **Drenaje quirúrgico**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

p. 42

Tema 11.7

Clase 11.7 en video

27 TEMA 11.7 · PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA

FOTO CLÍNICA

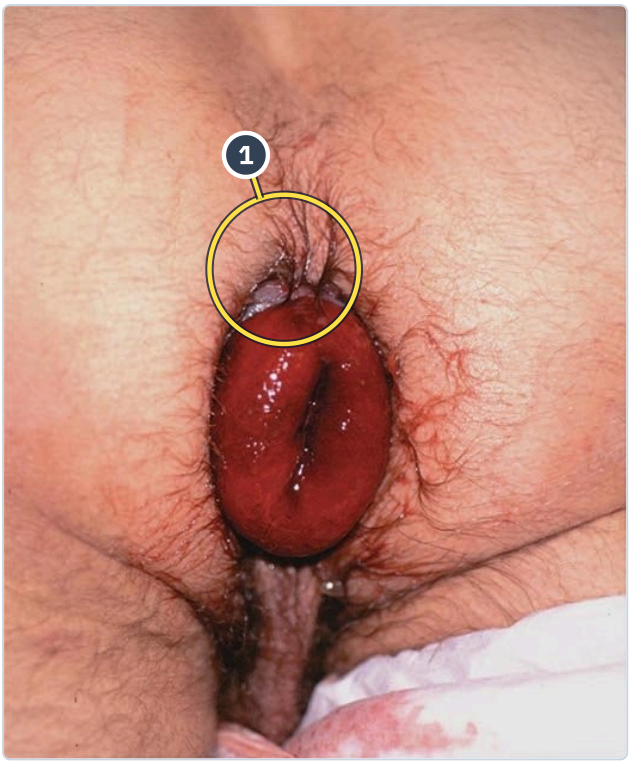


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 259

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegues concéntricos

DIAGNÓSTICO

Prolapso rectal

Mucosa con pliegues concéntricos.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía (rectopexia).

4.01.2.009 Prolapso rectal

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemorroides: pliegues radiados.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 40
Tema 11.7

Clase 11.7 en video

28 TEMA 11.8 · PATOLOGÍA PILONIDAL, HIDROSADENITIS & TUMORES BENIGNOS DE PARTES BLANDAS

FOTO CLÍNICA

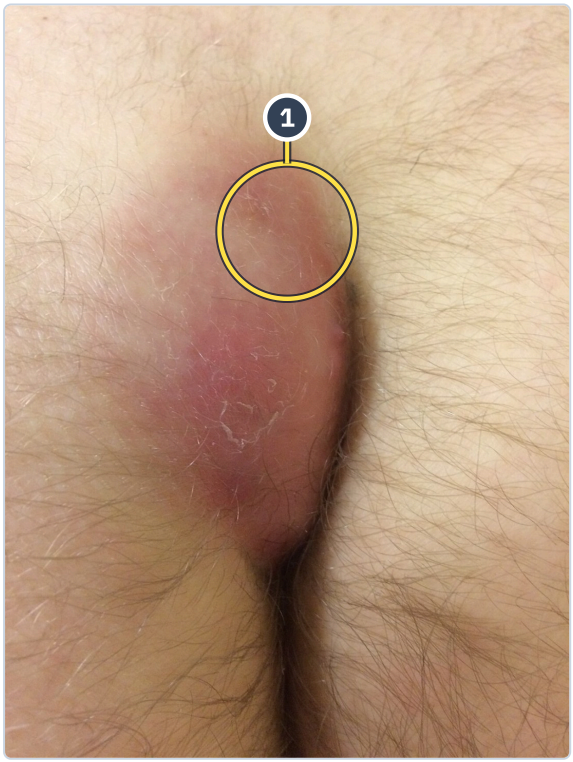


Imagen: Wikimedia Commons «Pilonidal abscess.jpg», CC BY-SA 4.0, Jonathanlund

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Absceso pilonidal

Masa fluctuante en el surco interglúteo.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje lateral a la línea media.

4.01.1.018 Enfermedades del seno pilonidal

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Absceso perianal: junto al ano.

PREGUNTA REAL

Agosto 2021 · P43 «Una paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso, en la zona interglútea, ubicado a dos centímetros de la línea media,…» → **Quiste pilonidal**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 45
Tema 11.8

Clase 11.8 en video

29 TEMA 11.8 · PATOLOGÍA PILONIDAL, HIDROSADENITIS & TUMORES BENIGNOS DE PARTES BLANDAS

FOTO CLÍNICA

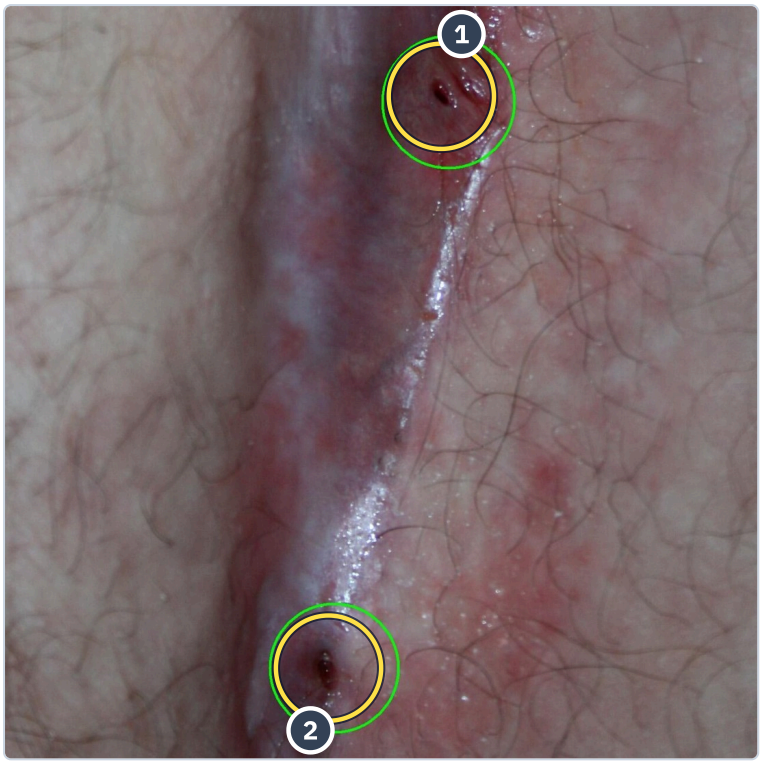


Imagen: Wikimedia Commons «Two pilonidal cysts in the natal cleft.jpg», Public domain, JerryTahl

QUÉ TIENES QUE VER

1. Orificio
2. Orificio

DIAGNÓSTICO

Sinus pilonidal

Orificios en la línea media (círculos).

CONDUCTA INICIAL

Crónico: resección quirúrgica.

`4.01.1.018` Enfermedades del seno pilonidal

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fístula anal: orificio cercano al ano.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 45** Tema 11.8

Clase 11.8 en video

30 TEMA 11.8 · PATOLOGÍA PILONIDAL, HIDROSADENITIS & TUMORES BENIGNOS DE PARTES BLANDAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Dermatología 14.ª ed., p. 61

QUÉ TIENES QUE VER

1. Trayectos fistulosos

DIAGNÓSTICO

Hidradenitis supurativa

Nódulos, fístulas y cicatrices en las ingles.

CONDUCTA INICIAL

Antibióticos, adalimumab o cirugía amplia.

`4.01.1.055` Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Forúnculo: lesión única.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 45** Tema 11.8

Clase 11.8 en video

31 TEMA 11.8 · PATOLOGÍA PILONIDAL, HIDROSADENITIS & TUMORES BENIGNOS DE PARTES BLANDAS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 402

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa

DIAGNÓSTICO

Sarcoma de partes blandas en la TAC

Masa retroperitoneal profunda mayor de 5 cm.

CONDUCTA INICIAL

Profundo y > 5 cm: biopsia en centro especializado antes de operar.

4.01.1.054 Tumores malignos de partes blandas
Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Lipoma: superficial y pequeño.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P101** «Un paciente de 18 años, consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que…» → **Solicitar ecografía de partes blandas**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 45** Tema 11.8

Clase 11.8 en video

32 TEMA 11.8 · PATOLOGÍA PILONIDAL, HIDROSADENITIS & TUMORES BENIGNOS DE PARTES BLANDAS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5179

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo rojo

DIAGNÓSTICO

Granuloma piogénico

Nódulo rojo, friable y pediculado que sangra.

CONDUCTA INICIAL

Resección o curetaje con biopsia.

6.01.1.012 Granuloma piogénico
Dx Sospecha | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Melanoma amelanótico: biopsia.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P62** «Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de…» → **Granuloma piógeno**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 45** Tema 11.8

Clase 11.8 en video

33 TEMA 11.19 · PATOLOGÍA VASCULAR PERIFÉRICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick, Dermatology in General Medicine, p. 1719

QUÉ TIENES QUE VER

1 Várices

DIAGNÓSTICO

Várices extensas

Venas tortuosas y dilatadas.

CONDUCTA INICIAL

Medias de compresión; cirugía si hay complicaciones.

`4.01.1.048` **Várices. Insuficiencia venosa crónica**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Telangiectasias: menores de 1 mm.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P26 «Mujer de 45 años con várices en extremidades inferiores bilaterales, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos. ¿Cuál es el…» → **Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias**…

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 49
Tema 11.19

Clase 11.19 en video

34 TEMA 11.19 · PATOLOGÍA VASCULAR PERIFÉRICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 994

QUÉ TIENES QUE VER

1 Piel indurada

DIAGNÓSTICO

Lipodermatoesclerosis

Piel indurada y pigmentada en el tercio distal (C4).

CONDUCTA INICIAL

Compresión elástica.

`4.01.1.048` **Várices. Insuficiencia venosa crónica**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Celulitis: aguda y febril.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 48
Tema 11.19

Clase 11.19 en video

35 TEMA 11.19 · PATOLOGÍA VASCULAR PERIFÉRICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 995

QUÉ TIENES QUE VER

1 Úlcera

DIAGNÓSTICO

Úlcera venosa

Úlcera maleolar medial con bordes irregulares y fondo granulante.

CONDUCTA INICIAL

Compresión: pilar del tratamiento.

4.01.1.050 **Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera arterial: dolorosa, distal.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P61 «Un paciente de 58 años, con antecedente de várices en ambas piernas, de gran tamaño, consulta porque hace dos semanas sufrió un pequeño trauma en…» → **Venosa**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 48
Tema 11.19

Clase 11.19 en video

36 TEMA 11.20 · OBESIDAD MÓRBIDA Y CIRUGÍA BARIÁTRICA

ESQUEMA

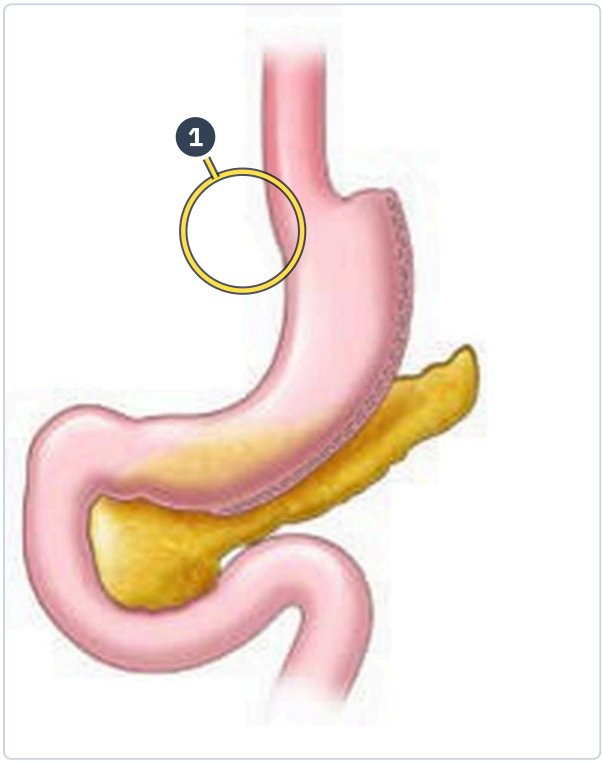


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 402-3

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estómago tubular

DIAGNÓSTICO

Manga gástrica

Se reseca cerca del 80% del estómago.

CONDUCTA INICIAL

Restrictiva.

4.01.1.060 **Obesidad mórbida**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bypass: también excluye el duodeno.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 53
Tema 11.20

Clase 11.20 en video

37 TEMA 11.20 · OBESIDAD MÓRBIDA Y CIRUGÍA BARIÁTRICA

ESQUEMA



Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 402-3

QUÉ TIENES QUE VER

1 Reservorio

DIAGNÓSTICO

Bypass en Y de Roux

Reservorio pequeño con exclusión del duodeno.

CONDUCTA INICIAL

Complicación típica: dumping.

4.01.1.060 Obesidad mórbida

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Manga: sin exclusión.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P75 «Una paciente de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace un año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea,…» → **Síndrome de dumping**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 54
Tema 11.20

Clase 11.20 en video

38 TEMA 11.9 · EVALUACIÓN INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 A: vía aérea

DIAGNÓSTICO

Evaluación primaria ATLS

A vía aérea y columna, B ventilación, C circulación, D neurológico, E exposición.

CONDUCTA INICIAL

Resolver cada problema antes de pasar al siguiente.

4.01.5.014 Evaluación primaria en trauma

examen/procedimiento

4.01.2.027 Trauma

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Evaluación secundaria: de pies a cabeza, después.

PREGUNTA REAL

Julio 2018 · P143 «Un paciente es recibido 30 minutos luego de un accidente de tránsito de alto impacto. Al ingreso tiene PA:100/60 mmHg, sin embargo, durante el…» → **Rotura de víscera sólida**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 64
Tema 11.9

Clase 11.9 en video

39 TEMA 11.9 · EVALUACIÓN INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO

ESQUEMA

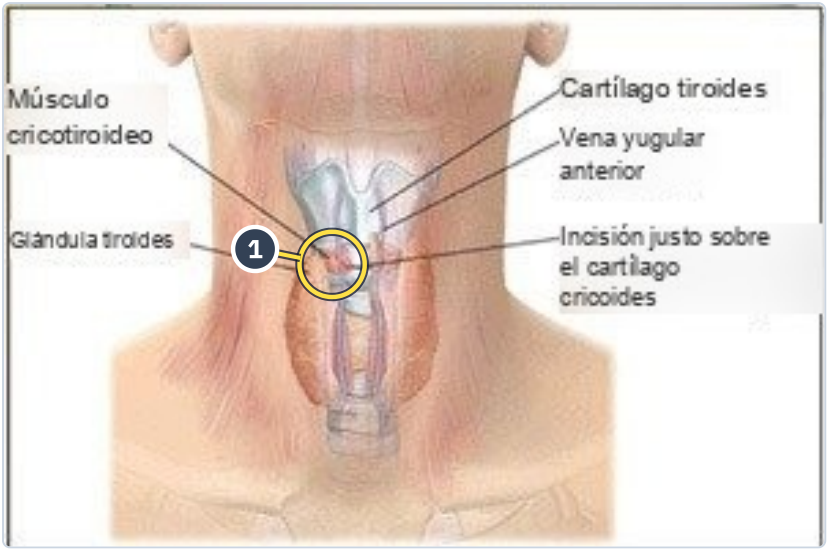


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 234

QUÉ TIENES QUE VER

1 Membrana cricotiroidea

DIAGNÓSTICO

Cricotiroidotomía

Incisión sobre la membrana cricotiroidea.

CONDUCTA INICIAL

No puedo intubar ni ventilar: vía aérea quirúrgica.

4.01.5.007	Cricoidostomía	examen/procedimiento
6.03.5.015	Traqueostomía y cricoidostomía	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Traqueostomía: más abajo, electiva.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P149 «Una paciente de 47 años con antecedente de neumonía severa por SARS-CoV-2 que requirió intubación y ventilación mecánica por 10 días, evoluciona…» → **Traqueostomía**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 64
Tema 11.9

Clase 11.9 en video

40 TEMA 11.9 · EVALUACIÓN INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO

IMAGEN RADIOLÓGICA

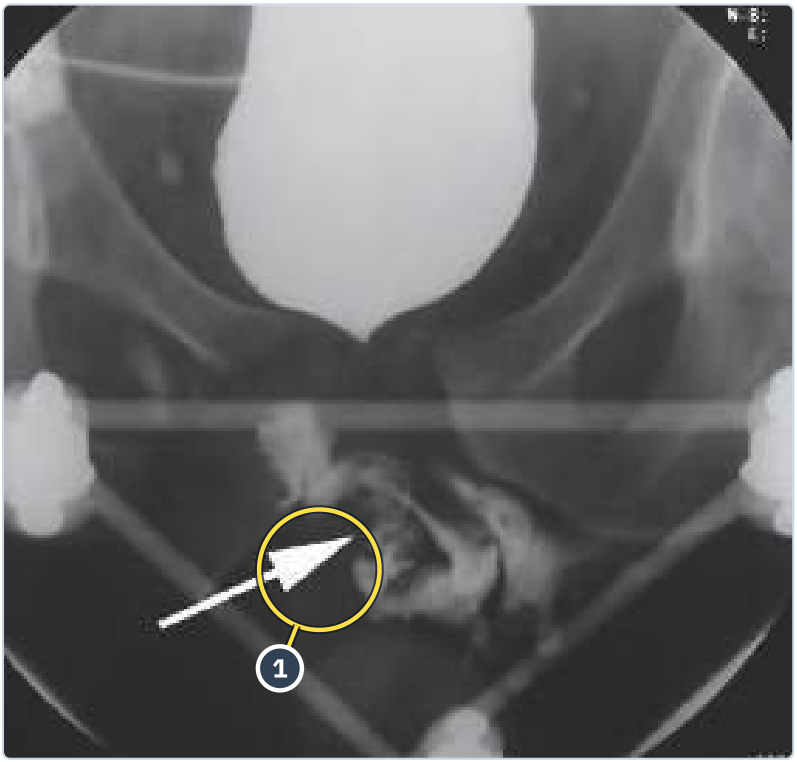


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 14.28

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fuga de contraste

DIAGNÓSTICO

Uretrografía: rotura uretral

Fuga de contraste (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Sangre en el meato: no sondear; cistostomía.

4.03.2.008	Trauma urológico	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Rotura vesical: contraste en el peritoneo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 64
Tema 11.9

Clase 11.9 en video

41 TEMA 11.10 · TRAUMA TORÁCICO MAYOR

IMAGEN RADIOLÓGICA

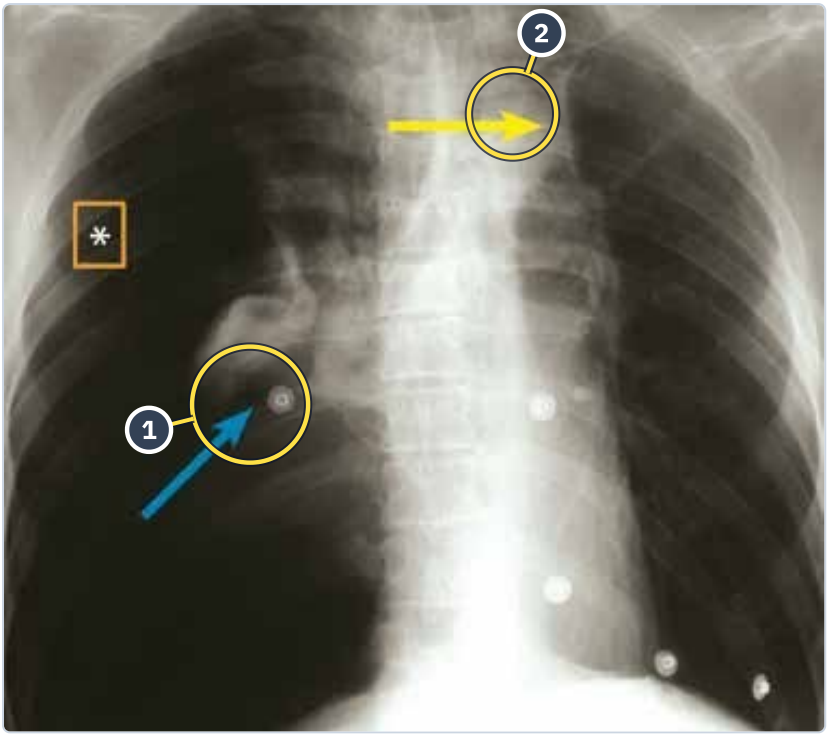


Imagen: Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 71

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pulmón colapsado
2. Mediastino desplazado

DIAGNÓSTICO

Neumotórax a tensión

Colapso pulmonar y desplazamiento del mediastino.

CONDUCTA INICIAL

Descompresión con aguja sin esperar la Rx.

1.05.2.011	Neumotórax hipertensivo	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
4.01.2.016	Traumatismo torácico grave	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemotórax: matidez.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P32 «Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y…» → **Pedir radiografía de tórax**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 69
Tema 11.10

Clase 11.10 en video

42 TEMA 11.10 · TRAUMA TORÁCICO MAYOR

IMAGEN RADIOLÓGICA

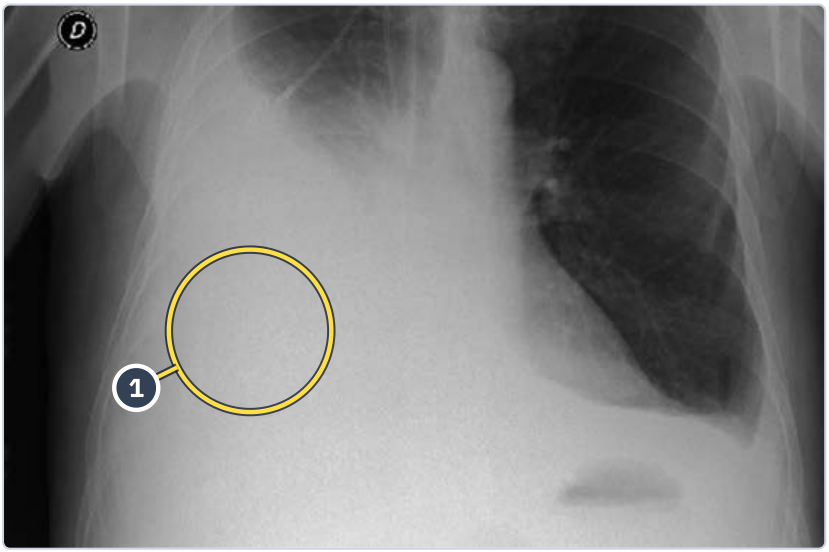


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

QUÉ TIENES QUE VER

1. Opacidad

DIAGNÓSTICO

Hemotórax

Opacidad del hemitórax.

CONDUCTA INICIAL

Tubo pleural; > 1.500 ml: toracotomía.

4.01.2.016	Traumatismo torácico grave	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.5.026	Drenaje pleural	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Neumotórax: hiperclaridad.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 69
Tema 11.10

Clase 11.10 en video

43 TEMA 11.10 · TRAUMA TORÁCICO MAYOR

ESQUEMA

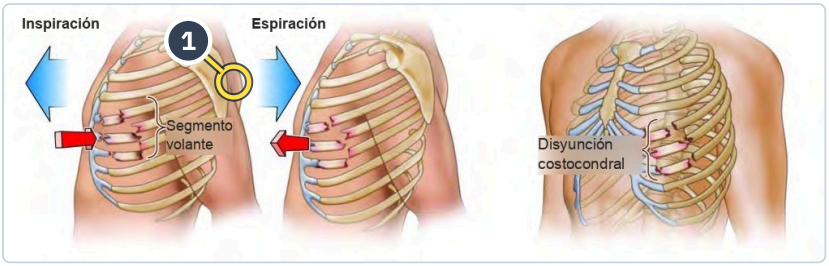


Imagen: ATLS 10.ª ed., p. 127

QUÉ TIENES QUE VER

1 Segmento volante

DIAGNÓSTICO

Tórax volante: movimiento paradójico

El segmento se hunde en la inspiración.

CONDUCTA INICIAL

Analgesia y ventilación; buscar contusión pulmonar.

4.01.2.016	Traumatismo torácico grave	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura costal única.

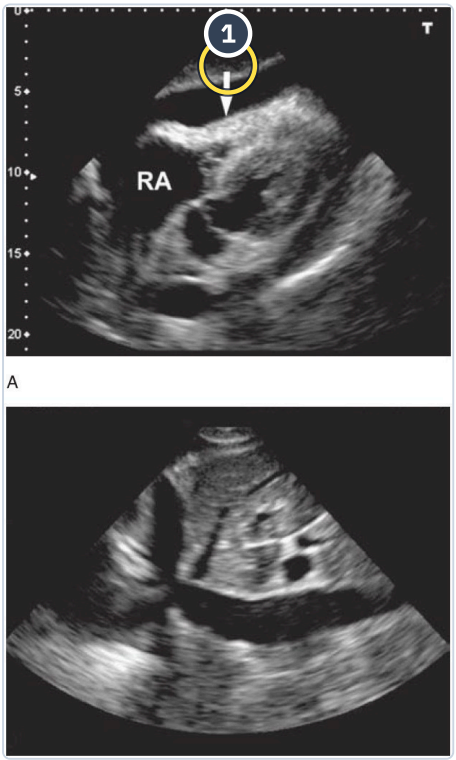
PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 70** Tema 11.10

Clase 11.10 en video

44 TEMA 11.10 · TRAUMA TORÁCICO MAYOR

ECOGRAFÍA



A

Imagen: Pocket Atlas of Emergency Ultrasound (Reardon, Ma), p. 146

QUÉ TIENES QUE VER

1 Derrame pericárdico

DIAGNÓSTICO

Taponamiento cardíaco en la FAST

Líquido pericárdico en la ventana subxifoidea (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Pericardiocentesis o toracotomía.

1.01.2.008	Taponamiento pericárdico	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.2.016	Traumatismo torácico grave	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Derrame pleural.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2024 · P158** «Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:» → **Ecocardiograma**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 72** Tema 11.10

Clase 11.10 en video

45 TEMA 11.11 · TRAUMA ABDOMINAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 124

QUÉ TIENES QUE VER

1 Equimosis

DIAGNÓSTICO

Signo del cinturón

Equimosis transversa en la pared abdominal.

CONDUCTA INICIAL

Sospechar rotura de intestino delgado y columna.

4.01.2.010 Trauma abdominal abierto y cerrado

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Erosión superficial.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 74** Tema 11.11

Clase 11.11 en video

46 TEMA 11.11 · TRAUMA ABDOMINAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 188

QUÉ TIENES QUE VER

1 Equimosis

DIAGNÓSTICO

Equimosis de flancos

Hematoma retroperitoneal.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste si está estable.

4.01.2.010 Trauma abdominal abierto y cerrado

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Equimosis por anticoagulantes.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 75** Tema 11.11

Clase 11.11 en video

47 TEMA 11.11 · TRAUMA ABDOMINAL

ECOGRAFÍA

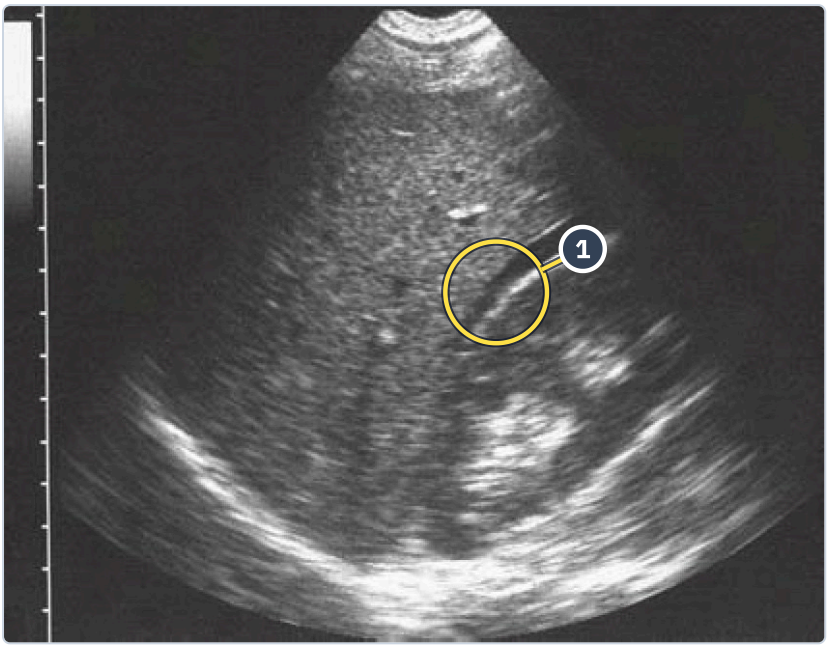


Imagen: Reardon, Pocket Atlas of Emergency Ultrasound, p. 64

QUÉ TIENES QUE VER

1 Líquido libre

DIAGNÓSTICO

FAST positiva

Líquido libre en el espacio de Morison.

CONDUCTA INICIAL

Inestable con FAST +: laparotomía.

4.01.2.010	Trauma abdominal abierto y cerrado	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.4.011	Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Vesícula: tiene pared.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P31 «Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos…» → **Realizar laparoscopía exploradora**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 75
Tema 11.11

Clase 11.11 en video

48 TEMA 11.12 · TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANO (TEC)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons «Bilateral periorbital ecchymosis (raccoon eyes).jpg», Public domain, Marion County Sheriff's Office

QUÉ TIENES QUE VER

1 Equimosis periorbitaria

DIAGNÓSTICO

Ojos de mapache

Equimosis periorbitaria bilateral: fractura de la base del cráneo.

CONDUCTA INICIAL

No pasar sonda nasogástrica.

1.10.2.020	Traumatismo encefalocraneano grave	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere
4.01.5.019	Intubación nasogástrica	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Trauma directo: unilateral.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 80
Tema 11.12

Clase 11.12 en video

49 TEMA 11.12 · TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANO (TEC)

FOTO CLÍNICA

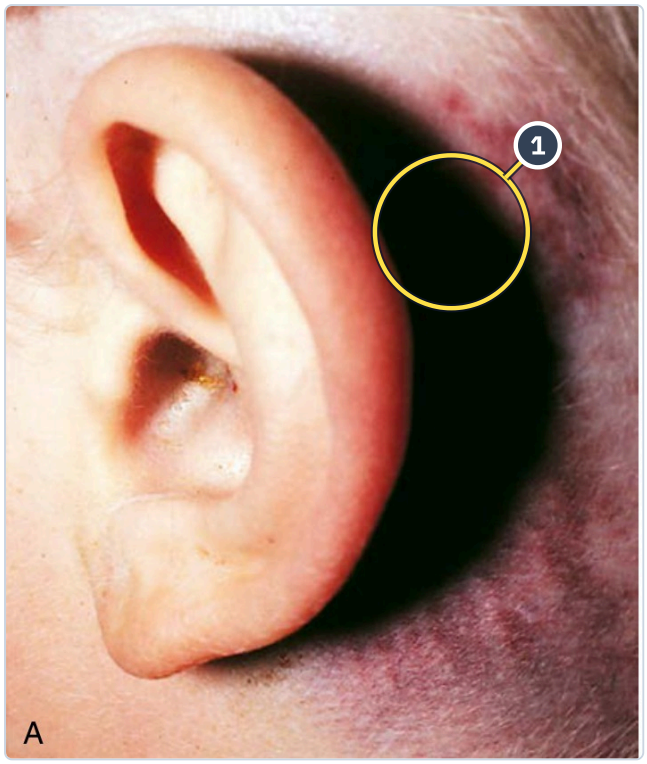


Imagen: Nelson 22.ª ed., Fig. 683.3A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Equimosis mastoidea

DIAGNÓSTICO

Signo de Battle

Equimosis retroauricular.

CONDUCTA INICIAL

Fractura de base de cráneo: TAC.

1.10.2.020 Traumatismo encefalocraneano grave
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Contusión local.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 80** Tema 11.12

Clase 11.12 en video

50 TEMA 11.12 · TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANO (TEC)

IMAGEN RADIOLÓGICA

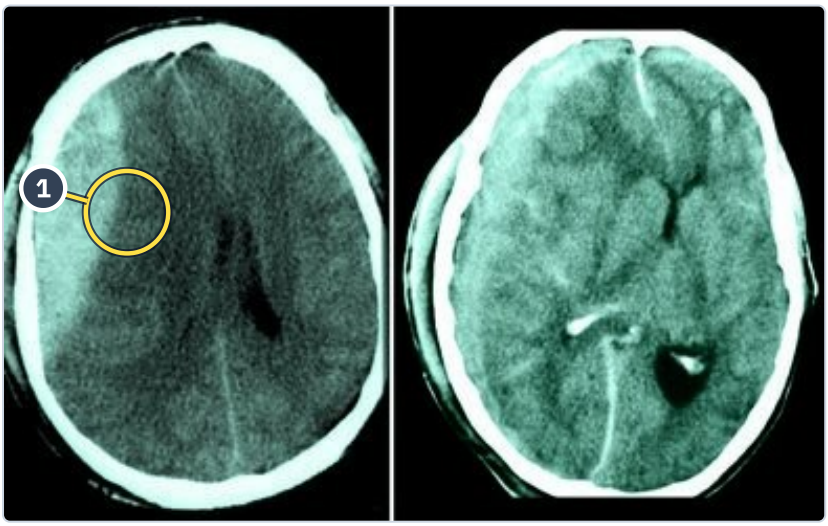


Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 142

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hematoma

DIAGNÓSTICO

Hematoma epidural vs subdural

Epidural: lente biconvexa; subdural: semiluna.

CONDUCTA INICIAL

Con efecto de masa: craneotomía urgente.

1.10.2.020 Traumatismo encefalocraneano grave
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.10.4.001 TAC de encefalo y columna
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Epidural: intervalo lúcido.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P97** «Un adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito, en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos…» → **Hematoma epidural derecho**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 80** Tema 11.12

Clase 11.12 en video

51 TEMA 11.12 · TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANO (TEC)

IMAGEN RADIOLÓGICA

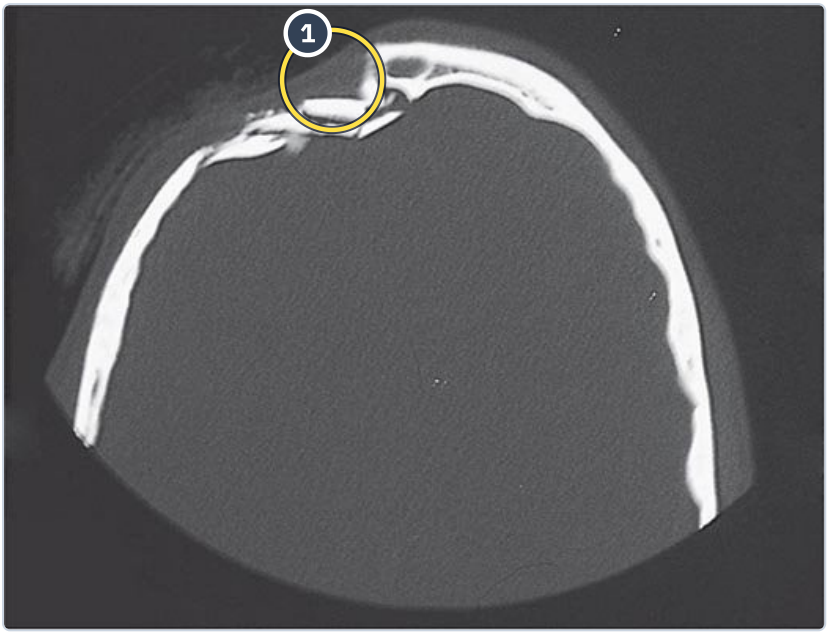


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 6

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hundimiento

DIAGNÓSTICO

Fractura con hundimiento

Fragmento óseo hundido en la ventana ósea.

CONDUCTA INICIAL

Hundimiento mayor que el grosor de la tabla: cirugía.

1.10.2.020 **Traumatismo encefalocraneano grave**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Sutura craneal normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 80** Tema 11.12

Clase 11.12 en video

52 TEMA 11.13 · QUEMADURAS GRAVES

ESQUEMA



Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 9-5

QUÉ TIENES QUE VER

1 Flictena

DIAGNÓSTICO

Quemadura de espesor parcial superficial

Flictenas, húmedas y muy dolorosas.

CONDUCTA INICIAL

Curación y analgesia; epiteliza en 2 semanas.

4.01.2.026 **Quemaduras**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.5.008 **Curación básica de quemaduras**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Primer grado: solo eritema.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 86** Tema 11.13

Clase 11.13 en video

53 TEMA 11.13 · QUEMADURAS GRAVES

ESQUEMA

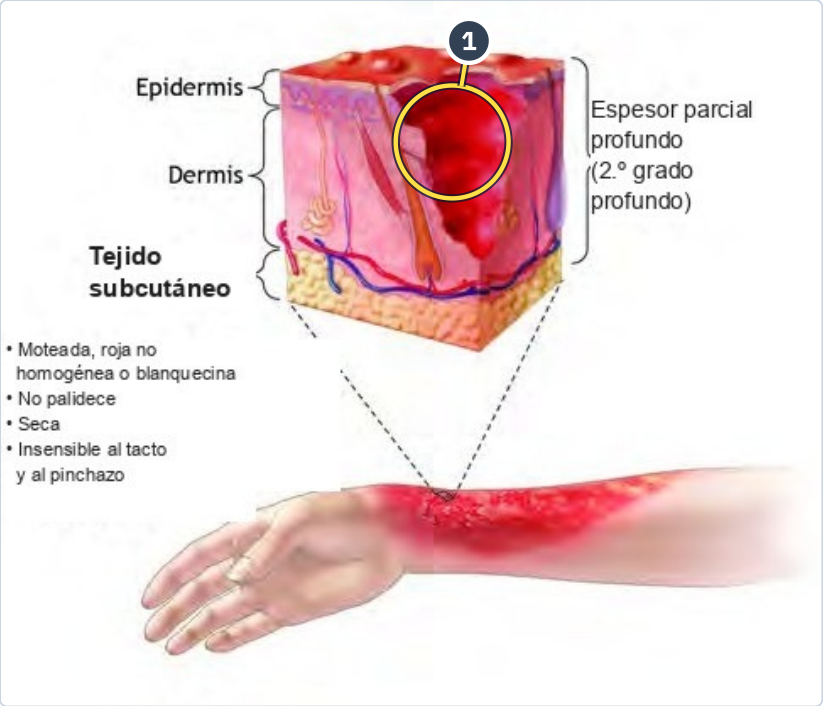


Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 9-5

QUÉ TIENES QUE VER

1 Dermis profunda

DIAGNÓSTICO

Quemadura de espesor parcial profundo

Pálida, seca y con poca sensibilidad.

CONDUCTA INICIAL

Puede requerir injerto.

4.01.2.026 Quemaduras — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tercer grado: escara acartonada.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 86
Tema 11.13

Clase 11.13 en video

54 TEMA 11.13 · QUEMADURAS GRAVES

FOTO CLÍNICA

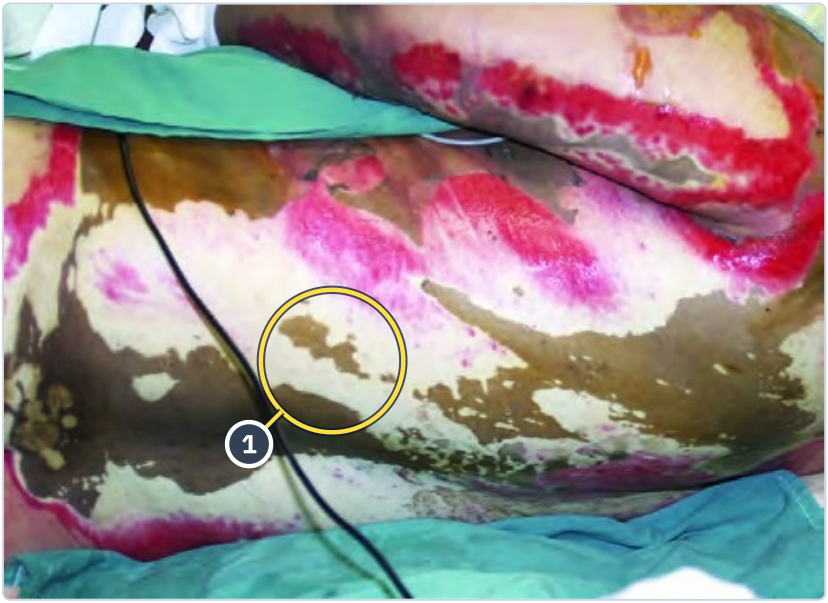


Imagen: ATLS 10.ª ed., Fig. 9-5

QUÉ TIENES QUE VER

1 Zona profunda

DIAGNÓSTICO

Quemadura de profundidad mixta

Zonas blancas acartonadas y zonas rojas.

CONDUCTA INICIAL

Parkland: 4 ml × kg × % SCQ en 24 h.

4.01.2.026 Quemaduras — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Escaldadura superficial.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P77 «Niño con quemadura en palmas y dedos, eritema importante y ampollas, inquieto e irritable en urgencias. ¿Cuál es la conducta inicial?» → **Indicar analgesia endovenosa**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA
p. 86
Tema 11.13

Clase 11.13 en video

55 TEMA 11.13 · QUEMADURAS GRAVES

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 95

QUÉ TIENES QUE VER

1 Incisión

DIAGNÓSTICO

Escarotomía

Incisión de la escara circunferencial.

CONDUCTA INICIAL

Quemadura circular profunda: escarotomía para liberar la circulación.

4.01.2.026 Quemaduras — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fasciotomía: incluye la fascia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 88** Tema 11.13

Clase 11.13 en video

56 TEMA 11.13 · QUEMADURAS GRAVES

FOTO CLÍNICA

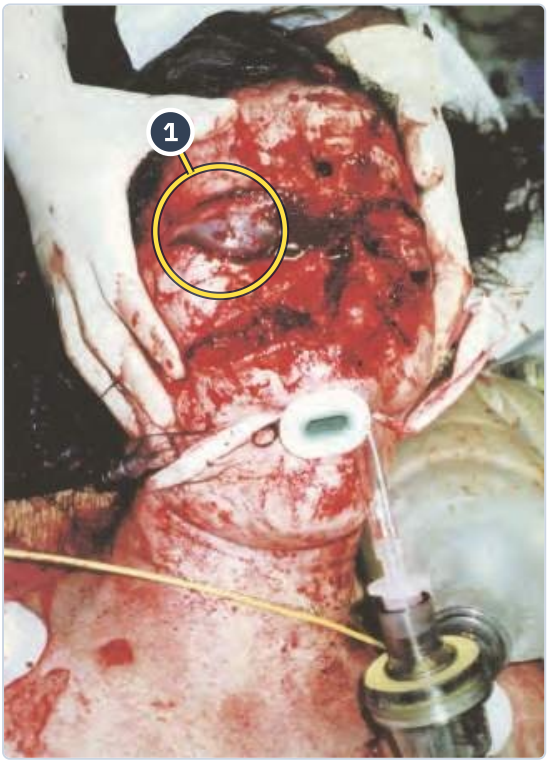


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cara quemada

DIAGNÓSTICO

Quemadura de la vía aérea

Quemaduras faciales con hollín.

CONDUCTA INICIAL

Intubación precoz.

4.01.2.026 Quemaduras — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.5.018 Intubación traqueal — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Quemadura facial superficial.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 88** Tema 11.13

Clase 11.13 en video

57 TEMA 11.13 · QUEMADURAS GRAVES

FOTO CLÍNICA

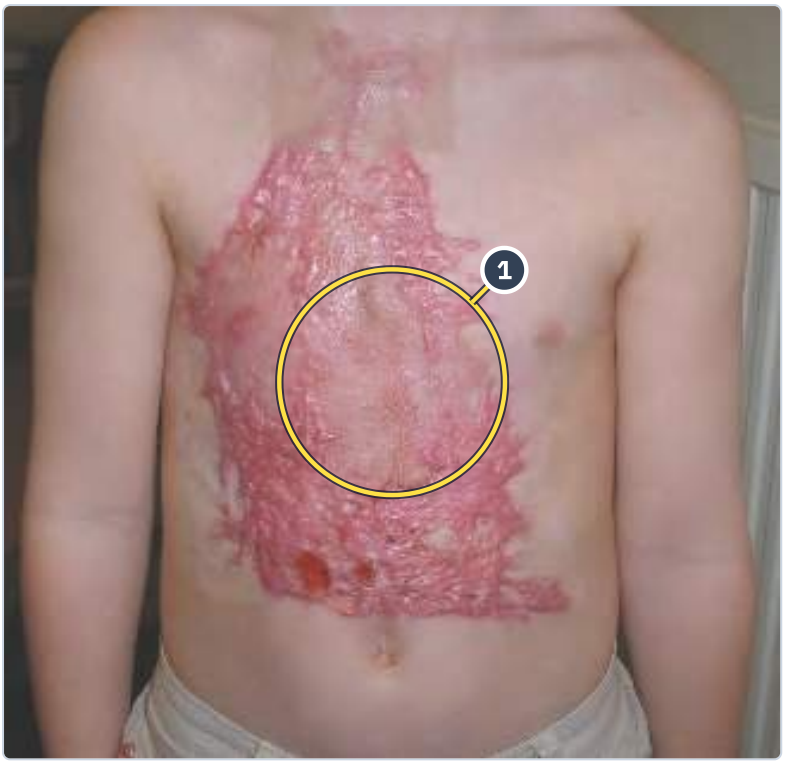


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 644

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cicatriz

DIAGNÓSTICO

Cicatriz hipertrófica

Cicatriz elevada dentro de los límites de la quemadura.

CONDUCTA INICIAL

Presoterapia y silicona; úlcera crónica: biopsia (Marjolin).

4.01.1.056 **Secuelas de quemaduras**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Queloide: sobrepasa el borde.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P161** «Un paciente de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua, de gran tamaño, en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención,…» → **Biopsia incisional**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 88** Tema 11.13

Clase 11.13 en video

58 TEMA 11.16 · FIEBRE POSTOPERATORIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

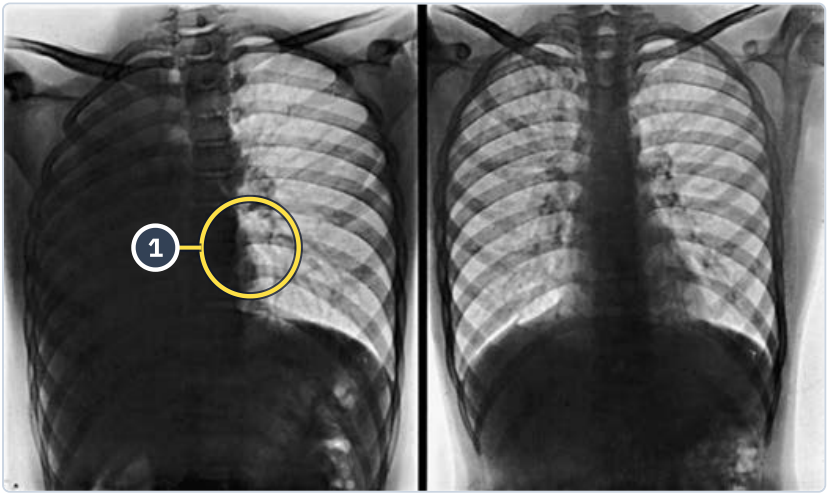


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3415

QUÉ TIENES QUE VER

1 Atelectasia

DIAGNÓSTICO

Atelectasia postoperatoria

Opacidad con pérdida de volumen.

CONDUCTA INICIAL

Kinesiterapia y deambulación precoz.

4.01.3.005 **Complicaciones postoperatorias frecuentes**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Neumonía: fiebre alta y broncograma.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P123** «Un paciente de 17 años, apendictomizado hace 6 horas, evoluciona con malestar general y dolor abdominal intenso. Su pulso es regular a 120…» → **Dehiscencia de la base apendicular**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 104** Tema 11.16

Clase 11.16 en video

59 TEMA 11.16 · FIEBRE POSTOPERATORIA

FOTO CLÍNICA

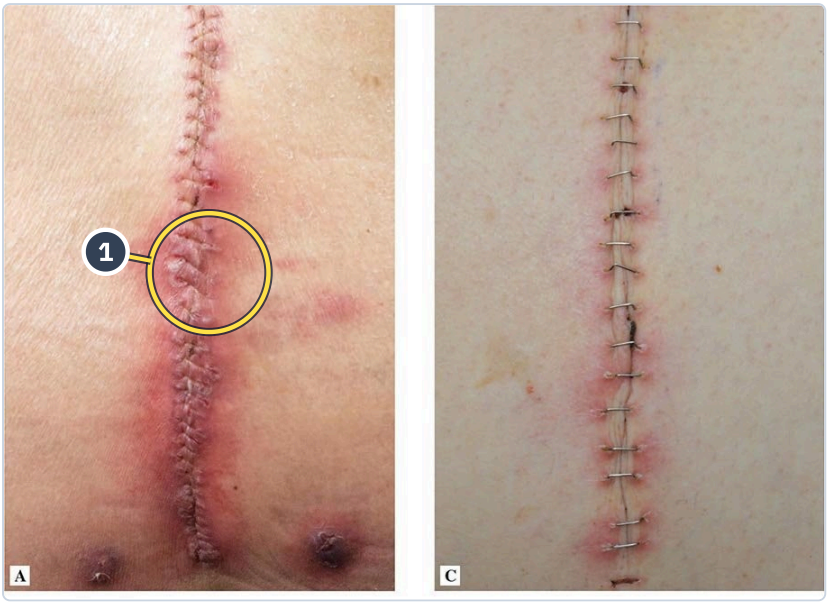


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 673

QUÉ TIENES QUE VER

1 Eritema

DIAGNÓSTICO

Herida operatoria infectada

Eritema alrededor de la sutura.

CONDUCTA INICIAL

Retirar puntos y drenar.

4.01.3.005 Complicaciones postoperatorias frecuentes — examen/procedimiento

4.01.3.016 Infección quirúrgica e intrahospitalaria — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Reacción a la sutura.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 104** Tema 11.16

Clase 11.16 en video

60 TEMA 11.16 · FIEBRE POSTOPERATORIA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pierna aumentada

DIAGNÓSTICO

TVP postoperatoria

Pantorrilla asimétrica (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Eco-Doppler y anticoagulación.

4.01.3.005 Complicaciones postoperatorias frecuentes — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Celulitis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 104** Tema 11.16

Clase 11.16 en video

61 TEMA 11.17 · INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO (ISQ), DEHISCENCIA DE HERIDA & EVISCERACIÓN AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 674

QUÉ TIENES QUE VER

1 Herida

DIAGNÓSTICO

Infección incisional superficial

Herida abierta con fibrina y bordes rojos.

CONDUCTA INICIAL

Curaciones; antibiótico si hay celulitis.

4.01.3.016 **Infección quirúrgica e intrahospitalaria**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Dehiscencia aponeurótica.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 108** Tema 11.17

Clase 11.17 en video

62 TEMA 11.17 · INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO (ISQ), DEHISCENCIA DE HERIDA & EVISCERACIÓN AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 25

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hematoma

DIAGNÓSTICO

Hematoma de herida

Herida abultada con sangre, no pus.

CONDUCTA INICIAL

Drenar; puede avisar de una hemorragia.

4.01.2.024 **Hemorragia aguda post operatoria.**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Infección: pus y fiebre.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P148** «Un paciente, apendictomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto y su…» → **Hemoperitoneo**

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 108** Tema 11.17

Clase 11.17 en video

63 TEMA 11.17 · INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO (ISQ), DEHISCENCIA DE HERIDA & EVISCERACIÓN AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 26

QUÉ TIENES QUE VER

1 Desbridamiento

DIAGNÓSTICO

Fascitis necrotizante postoperatoria

Desbridamiento amplio de tejido necrótico.

CONDUCTA INICIAL

Dolor desproporcionado: cirugía urgente.

4.01.3.016 **Infección quirúrgica e intrahospitalaria**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Celulitis: sin necrosis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 108** Tema 11.17

Clase 11.17 en video

64 TEMA 11.17 · INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO (ISQ), DEHISCENCIA DE HERIDA & EVISCERACIÓN AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 67

QUÉ TIENES QUE VER

1 Orificio fistuloso

DIAGNÓSTICO

Fístula enterocutánea

Salida de contenido intestinal por la herida.

CONDUCTA INICIAL

Control del débito y nutrición.

4.01.1.011 **Fístulas del intestino delgado**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Absceso de pared.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 108** Tema 11.17

Clase 11.17 en video

65 TEMA 11.18 · MANEJO DE HERIDAS TRAUMÁTICAS, MORDEDURAS ANIMALES/HUMANAS & PROFILAXIS ANTITETÁNICA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Celulitis

DIAGNÓSTICO

Mordedura de gato infectada

Colmillos finos que inoculan Pasteurella.

CONDUCTA INICIAL

Amoxicilina-clavulánico profiláctico.

1.04.3.002 Mordeduras de animales — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Mordedura de perro: más desgarro.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 113** Tema 11.18

Clase 11.18 en video

66 TEMA 11.18 · MANEJO DE HERIDAS TRAUMÁTICAS, MORDEDURAS ANIMALES/HUMANAS & PROFILAXIS ANTITETÁNICA

FOTO CLÍNICA

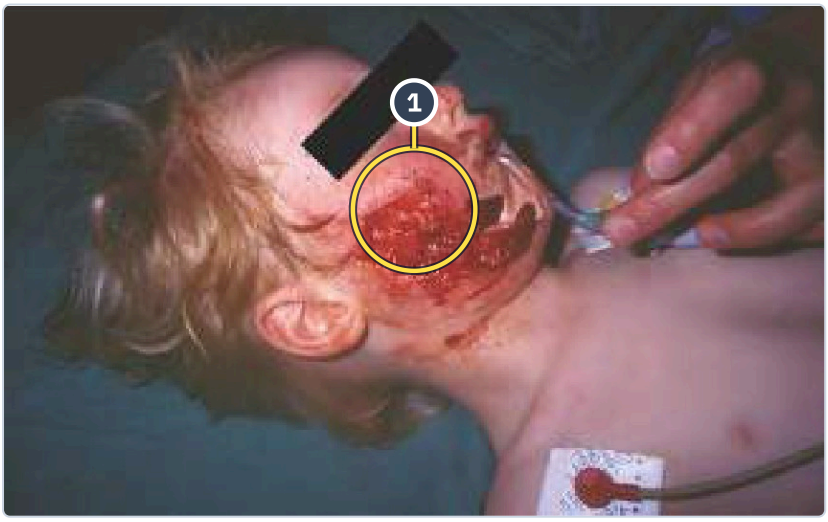


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 3.4

QUÉ TIENES QUE VER

1 Herida desgarrada

DIAGNÓSTICO

Mordedura de perro

Desgarro y aplastamiento.

CONDUCTA INICIAL

Aseo, sutura en cara; profilaxis antirrábica y antitetánica.

1.04.3.002 Mordeduras de animales — examen/procedimiento

4.01.3.018 Tratamiento antitetánico y antirrábico — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Herida limpia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 113** Tema 11.18

Clase 11.18 en video

67 TEMA 11.18 · MANEJO DE HERIDAS TRAUMÁTICAS, MORDEDURAS ANIMALES/HUMANAS & PROFILAXIS ANTITETÁNICA

FOTO CLÍNICA

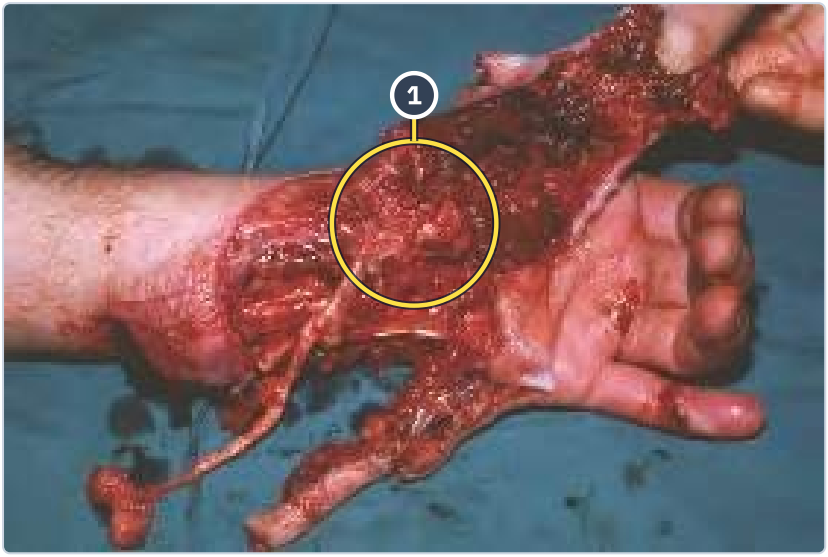


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 47

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tendones expuestos

DIAGNÓSTICO

Herida avulsiva de la mano

Herida complicada con daño de tendones.

CONDUCTA INICIAL

Derivar a cirugía de mano.

4.02.2.009 Heridas de la mano no complicadas

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Herida no complicada: sutura en APS.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 113** Tema 11.18

Clase 11.18 en video

68 TEMA 11.18 · MANEJO DE HERIDAS TRAUMÁTICAS, MORDEDURAS ANIMALES/HUMANAS & PROFILAXIS ANTITETÁNICA

FOTO CLÍNICA

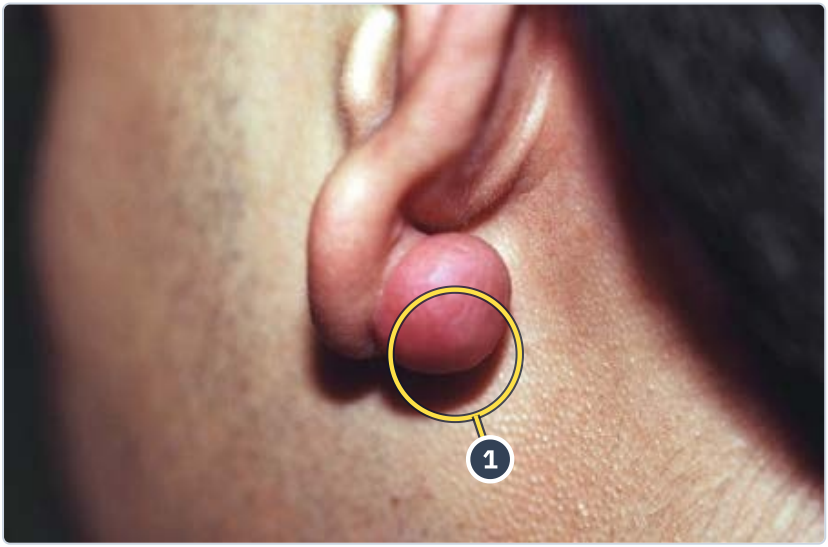


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5268

QUÉ TIENES QUE VER

1 Queloide

DIAGNÓSTICO

Queloide del lóbulo

Masa cicatricial que sobrepasa el borde.

CONDUCTA INICIAL

Corticoide intralesional.

4.01.1.057 Cicatrices viciosas

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipertrófica: respeta el borde.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 112** Tema 11.18

Clase 11.18 en video

69 TEMA 11.21 · PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR — ESQUEMA



Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 361

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bloqueo digital

DIAGNÓSTICO

Onicectomía parcial

Bloqueo digital y resección de la aleta.

CONDUCTA INICIAL

Lidocaína sin adrenalina.

4.01.5.024	Onicectomía — examen/procedimiento
4.01.1.059	Onicocriptosis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Paroniquia: absceso sin uña encarnada.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA **p. 116** Tema 11.21

Clase 11.21 en video

Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Obstrucción de delgado vs colon



VS



A Obstrucción de intestino delgado

- Asas centrales

Ficha n.° 13 · p. 10

B Obstrucción de colon

- Marco periférico

Ficha n.° 14 · p. 10

LA DIFERENCIA En colon, pensar en cáncer o vólvulo.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hemorroides vs prolapso rectal



VS



A Prolapso hemorroidal grado IV

- Pliegues radiados

Ficha n.° 24 · p. 15

B Prolapso rectal

- Pliegues concéntricos

Ficha n.° 27 · p. 17

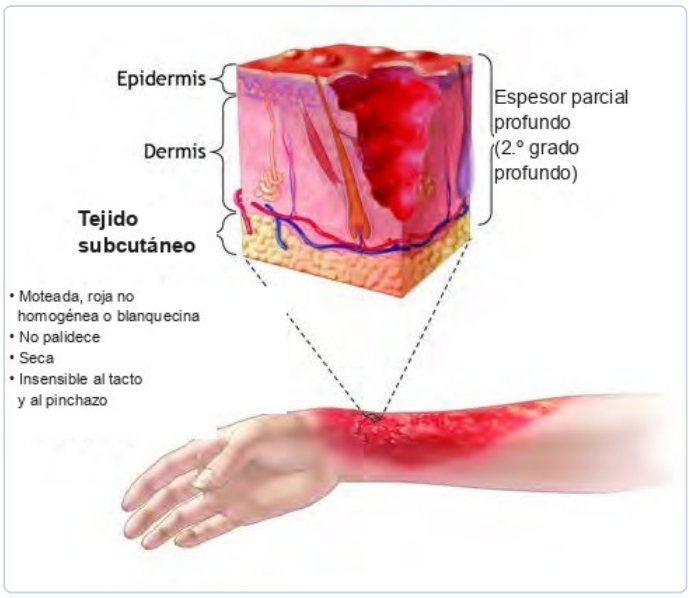
LA DIFERENCIA Los pliegues los separan.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Espesor parcial superficial vs profundo



VS



A Quemadura de espesor parcial superficial

- Húmeda y dolorosa

Ficha n.° 52 · p. 29

B Quemadura de espesor parcial profundo

- Seca y poco dolorosa

Ficha n.° 53 · p. 30

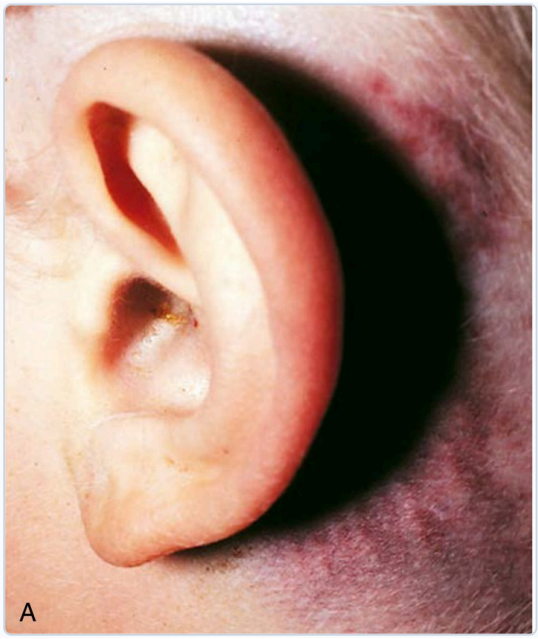
LA DIFERENCIA La profunda puede requerir injerto.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Signos de fractura de base de cráneo



VS



A Ojos de mapache

- Periorbitario

Ficha n.° 48 · p. 27

B Signo de Battle

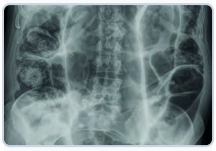
- Retroauricular

Ficha n.° 49 · p. 28

LA DIFERENCIA Ninguno permite sonda nasal.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



GRANO DE CAFÉ

Asa sigmoidea dilatada en U invertida.

Se ve en: Vólvulo de sigmoides.

Tomo p. 21 · Atlas: ficha n.° 15, p. 11



OJOS DE MAPACHE

Equimosis periorbitaria bilateral.

Se ve en: Fractura de base de cráneo.

Tomo p. 80 · Atlas: ficha n.° 48, p. 27



SIGNO DE BATTLE

Equimosis retroauricular.

Se ve en: Fractura de base de cráneo.

Tomo p. 80 · Atlas: ficha n.° 49, p. 28



SIGNO DEL CINTURÓN

Equimosis transversa abdominal.

Se ve en: Lesión de víscera hueca.

Tomo p. 74 · Atlas: ficha n.° 45, p. 26

Índice por tipo de imagen

31	11	22	5
FOTO CLÍNICA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	ECOGRAFÍA

Foto clínica · 31

22 Hernia umbilical incarcerada (11.6) 14
23 Fisura anal (11.7) 15
24 Prolapso hemorroidal grado IV (11.7) 15
25 Hemorroide externa trombosada (11.7) 16
26 Absceso perianal (11.7) 16
27 Prolapso rectal (11.7) 17
28 Absceso pilonidal (11.8) 17
29 Sinus pilonidal (11.8) 18
30 Hidradenitis supurativa (11.8) 18
32 Granuloma piogénico (11.8) 19
33 Várices extensas (11.19) 20
34 Lipodermatoesclerosis (11.19) 20
35 Úlcera venosa (11.19) 21
45 Signo del cinturón (11.11) 26
46 Equimosis de flancos (11.11) 26
48 Ojos de mapache (11.12) 27
49 Signo de Battle (11.12) 28
54 Quemadura de profundidad mixta (11.13) 30
55 Escarotomía (11.13) 31
56 Quemadura de la vía aérea (11.13) 31
57 Cicatriz hipertrófica (11.13) 32
59 Herida operatoria infectada (11.16) 33
60 TVP postoperatoria (11.16) 33
61 Infección incisional superficial (11.17) 34
62 Hematoma de herida (11.17) 34
63 Fascitis necrotizante postoperatoria (11.17) 35
64 Fístula enterocutánea (11.17) 35
65 Mordedura de gato infectada (11.18) 36
66 Mordedura de perro (11.18) 36
67 Herida avulsiva de la mano (11.18) 37
68 Queloide del lóbulo (11.18) 37

Esquema · 11

02 Puntos y signos del examen (11.1) 4
20 Hernia inguinal directa vs indirecta (11.6) 13
21 Asa sana y estrangulada (11.6) 14
36 Manga gástrica (11.20) 21
37 Bypass en Y de Roux (11.20) 22
38 Evaluación primaria ATLS (11.9) 22
39 Cricotiroidotomía (11.9) 23
43 Tórax volante: movimiento paradójico (11.10) 25
52 Quemadura de espesor parcial superficial (11.13) 29
53 Quemadura de espesor parcial profundo (11.13) 30
69 Onicectomía parcial (11.21) 38

Imagen radiológica · 22

01 Fecalito en la fosa ilíaca derecha (11.1) 4
03 Apendicitis en la TAC (11.1) 5
05 Plastrón o absceso apendicular (11.1) 6
08 Cintigrafía HIDA (11.2) 7
09 Diverticulitis en la TAC (11.3) 8
10 Diverticulitis leve (Hinchey 0–IA) (11.3) 8
11 Absceso pericólico (Hinchey IB–II) (11.3) 9
12 Diverticulitis perforada (Hinchey IV) (11.3) 9
13 Obstrucción de intestino delgado (11.4) 10
14 Obstrucción de colon (11.4) 10
15 Vólvulo de sigmoides (11.4) 11
16 Gas portal en la TAC (11.4) 11
17 Neumoperitoneo (11.5) 12
18 Neumoperitoneo evidente (11.5) 12
19 Hernia inguinoescrotal (11.6) 13
31 Sarcoma de partes blandas en la TAC (11.8) 19
40 Uretrografía: rotura uretral (11.9) 23
41 Neumotórax a tensión (11.10) 24
42 Hemotórax (11.10) 24
50 Hematoma epidural vs subdural (11.12) 28
51 Fractura con hundimiento (11.12) 29
58 Atelectasia postoperatoria (11.16) 32

Ecografía · 5

04 Ecografía de apendicitis (11.1) 5
06 Cálculos con sombra acústica (11.2) 6
07 Colecistitis aguda en la ecografía (11.2) 7
44 Taponamiento cardíaco en la FAST (11.10) 25
47 FAST positiva (11.11) 27

Autoevaluación

6 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

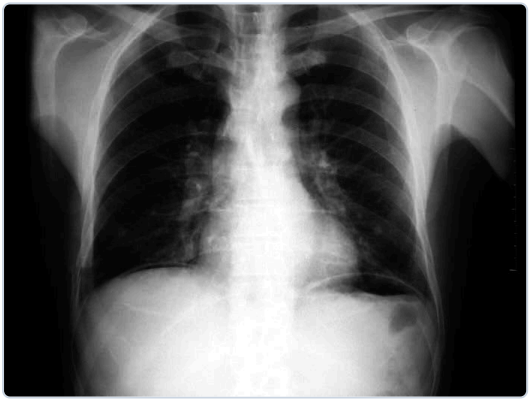
1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



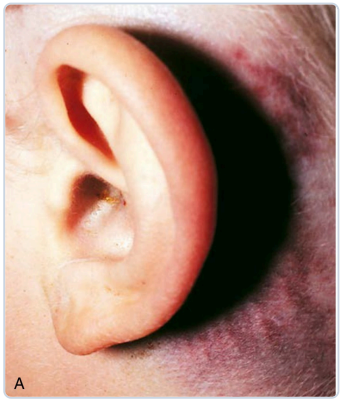
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Colecistitis aguda en la ecografía**	Pared engrosada	07 · p. 7
2	**Obstrucción de intestino delgado**	Asas dilatadas	13 · p. 10
3	**Neumoperitoneo**	Aire subdiafragmático	17 · p. 12
4	**Úlcera venosa**	Úlcera	35 · p. 21
5	**Ojos de mapache**	Equimosis periorbitaria	48 · p. 27
6	**Signo de Battle**	Equimosis mastoidea	49 · p. 28